

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Escuela Académico Profesional de Psicología

Tesis

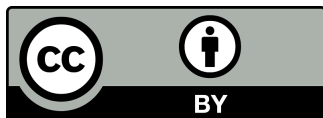
**Autolesiones e impulsividad en estudiantes de nivel
secundario de una institución educativa del distrito
de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025**

Yanet Huaman Huaman

Para optar el Título Profesional de
Licenciado en Psicología

Cusco, 2026

Repositorio Institucional Continental
Tesis digital



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

INFORME DE CONFORMIDAD DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

A : Decano de la Facultad de Psicología
DE : Mayra Vanessa Garcia Perez
Asesor de trabajo de investigación
ASUNTO : Remito resultado de evaluación de originalidad de trabajo de investigación
FECHA : 15 de Mayo de 2026

Con sumo agrado me dirijo a vuestro despacho para informar que, en mi condición de asesor del trabajo de investigación:

Título:

Autolesiones e Impulsividad en Estudiantes de Nivel Secundaria de una Institución Educativa del Distrito de Andahuaylillas de la Provincia de Quispicanchi-Cusco, 2025

Autores:

1. Yanet Huaman Huaman – Carrera profesional Psicología

Se procedió con la carga del documento a la plataforma "Turnitin" y se realizó la verificación completa de las coincidencias resaltadas por el software dando por resultado 19 % de similitud sin encontrarse hallazgos relacionados a plagio. Se utilizaron los siguientes filtros:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| • Filtro de exclusión de bibliografía | SI ☒ | NO ☐ |
| • Filtro de exclusión de grupos de palabras menores
Nº de palabras excluidas (en caso de elegir "SI"): 10 | SI ☒ | NO ☐ |
| • Exclusión de fuente por trabajo anterior del mismo estudiante | SI ☒ | NO ☐ |

En consecuencia, se determina que el trabajo de investigación constituye un documento original al presentar similitud de otros autores (citas) por debajo del porcentaje establecido por la Universidad Continental.

Recae toda responsabilidad del contenido del trabajo de investigación sobre el autor y asesor, en concordancia a los principios expresados en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos – RENATI y en la normativa de la Universidad Continental.

Atentamente,

La firma del asesor obra en el archivo original
(No se muestra en este documento por estar expuesto a publicación)

Dedicatoria

A mis padres, por su amor incondicional, su apoyo constante y por enseñarme con su ejemplo el valor del esfuerzo y la perseverancia. A mis dos hermanitas, quienes con su ternura y alegría llenaron de luz cada etapa de este camino.

Este logro es tan mío como de ustedes.

Agradecimiento

A Dios, por darme la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar esta etapa tan importante de mi vida.

A mis padres, por creer siempre en mí, por sus sacrificios y por ser mi mayor fuente de inspiración.

A mis hermanitas, por motivarme a seguir adelante y recordarme cada día la importancia de soñar en grande.

A mis docentes y compañeros de la carrera de Psicología, por su guía, amistad y por los valiosos aprendizajes compartidos.

Gracias a todos los que, de una u otra manera, fueron parte de este proceso y contribuyeron a que este sueño hoy sea una realidad.

Resumen

Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación entre las autolesiones y la impulsividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas de la provincia de Quispicanchi-Cusco, 2025. Para ello, se siguió un enfoque cuantitativo, de tipo teórico, de diseño no experimental y correlacional. Se contó con una muestra de 230 alumnos de secundaria, establecidos mediante un método de muestreo censal. Con el objetivo de obtener la información más relevante de los estudiantes, se empleó la Escala de autolesiones de Cartolin y Palma junto a la Escala de impulsividad de Barratt.

Los resultados identificaron que las autolesiones y la impulsividad en estudiantes de secundaria presentan una correlación directa y significativa; además, se encontró que para las autolesiones un 83.5 % alcanzó un interés clínicamente no significativo, mientras que para la impulsividad el 59.6 % obtuvo un grado bajo de impulsividad, mientras que el 11.3 %, un grado moderado y un 29.1 %, un grado alto de impulsividad.

Palabras clave: Impulsividad, autolesiones, estudiantes.

Abstract

The purpose of this research was to determine the relationship between self-harm and impulsivity in secondary school students at an educational institution in the district of Andahuaylillas in the province of Quispicanchi-Cusco, 2025. A quantitative, theoretical, non-experimental, correlational approach was used. The sample consisted of 230 fifth-year secondary school students, selected using a census sampling method. In order to obtain the most relevant information from the students, the Cartolin and Palma Self-Harm Scale was used together with the Barratt Impulsivity Scale.

The results identified that self-harm and impulsivity in secondary school students have a direct and significant correlation. It was also found that 83.5% of self-harm cases reached a clinically insignificant level, while 59.6% of impulsivity cases obtained a low degree of impulsivity, while 11.3% had a moderate degree and 29.1% had a high degree of impulsivity.

Keywords: Impulsivity, self-harm, students.

Índice

Dedicatoria.....	iv
Agradecimiento.....	v
Resumen	vi
Abstract.....	vii
Índice	viii
Índice de tablas	xii
Introducción	xiii
CAPITULO I.....	16
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.....	16
1.1. Planteamiento del Problema.....	16
1.2. Formulación del Problema	22
1.2.1. Problema general	22
1.2.2. Problema específico.....	22
1.3. Objetivos de la investigación	22
1.3.1. Objetivo general	22
1.3.2. Objetivo específico	22
1.4. Justificación de la investigación.....	23
1.4.1. Justificación teórica	23
1.4.2. Justificación práctica	23
1.4.3. Justificación metodológica	24
1.4.4. Aporte social.....	24
1.5. Viabilidad.....	25
CAPÍTULO II.....	26
MARCO TEÓRICO	26

2.1. Antecedentes de la investigación.....	26
2.1.1. Antecedentes internacionales	26
2.1.2. Antecedentes nacionales.....	28
2.1.3. Antecedentes locales	30
2.2. Bases teóricas	33
2.2.1. Autolesión	33
2.2.1.1. Definición conceptual	33
2.2.1.2. Ciclo de la autolesión	35
2.2.1.3. Características sintomáticas definitorias	36
2.2.1.4. Factores determinantes de la conducta autolesiva.....	37
2.2.1.5. Modelos teóricos	39
2.2.1.6. Dimensiones de las autolesiones	40
2.2.1.7. Autolesión en la adolescencia	41
2.2.2. Impulsividad.....	44
2.2.2.1. Definición de la impulsividad	44
2.2.2.2. Características de personas con impulsividad	46
2.2.2.3. Origen de la impulsividad	48
2.2.2.4. Teorías de la impulsividad	49
2.2.2.5. Dimensiones de la impulsividad.....	51
2.2.2.6. Factores predisponentes de la impulsividad en la adolescencia	52
2.2.2.7. Consecuencias de la impulsividad en la adolescencia.....	54
2.2.2.8. Aspectos que influyen en la impulsividad de acuerdo con Barratt	57
2.3. Definición de términos básicos	58
CAPÍTULO III.....	60
HIPÓTESIS	60

3. Hipótesis.....	60
3.1. Hipótesis general	60
3.2. Hipótesis específica	60
Hipótesis específica 2:.....	60
3.3. Matriz de operacionalización de las variables.....	56
CAPÍTULO IV	59
METODOLOGÍA	59
4.1. Enfoque de la investigación	59
4.2. Método	59
4.3. Tipo.....	59
4.4. Alcance o nivel	59
4.5. Diseño de la investigación	59
4.6. Población, muestra, selección de la muestra.....	60
4.6.1. Población	60
Criterios de inclusión.....	60
Criterios de exclusión.....	61
4.6.2. Muestra	61
4.6.3. Selección de la muestra.....	61
Participantes	62
4.7. Técnicas de recolección de datos.....	62
Instrumentos: Ficha Técnica	62
Validez y confiabilidad Validez	63
Instrumento 2 – Escala de impulsividad de Barratt.....	64
Validez y confiabilidad	65
4.8. Técnicas de análisis de datos	66

4.9. Aspectos éticos	66
CAPÍTULO V	67
RESULTADOS	67
5.1. Resultados de la investigación	67
5.1.1. Resultados inferenciales.....	67
5.1.2. Resultados descriptivos.....	69
5.1.2.1. Autolesiones.....	69
5.1.2.2. Impulsividad	70
5.2. Discusión de resultados.....	70
CONCLUSIONES	77
RECOMENDACIONES	79
REFERENCIAS.....	81

Índice de tablas

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables	56
Tabla 2. Población de la investigación	60
Tabla 3. Género de la muestra	61
Tabla 4. Edad de la muestra.....	62
Tabla 5. Prueba de normalidad de las variables.....	67
Tabla 6. Correlación entre autolesiones e impulsividad	67
Tabla 7. Correlación entre dimensión adaptabilidad e impulsividad.....	68
Tabla 8. Correlación entre dimensión regulación afectiva e impulsividad.....	69
Tabla 9. Niveles de autolesiones.....	69
Tabla 10. Niveles de impulsividad.....	70

Introducción

En los últimos años, las autolesiones se han convertido en un tema de gran interés en el campo de la salud mental, principalmente por el aumento de su frecuencia en adolescentes y jóvenes. Este comportamiento hace referencia a aquellas acciones en las que una persona se provoca daño de manera intencional en su cuerpo, sin que exista un deseo de acabar con su vida. De acuerdo con Favazza (1998), la autolesión puede entenderse como un acto deliberado de dañar o alterar el tejido corporal, sin que exista un motivo suicida. Estas conductas suelen estar relacionadas con dificultades para manejar las emociones, así como con entornos personales o sociales marcados por situaciones de vulnerabilidad.

De otro lado, la impulsividad es un rasgo de personalidad que suele asociarse con la aparición de conductas autolesivas. Barratt (1994) la describe como la tendencia a responder de manera rápida y poco planificada, sin tomar en cuenta las posibles consecuencias negativas de dichas conductas. Esto implica que las personas con altos niveles de impulsividad pueden tener mayor dificultad para controlar sus acciones y, en consecuencia, mostrarse más propensas a realizar conductas que atenten contra su integridad física.

Comprender cómo se relacionan la impulsividad y las autolesiones resulta fundamental tanto para la psicología clínica como para la educativa. El análisis de estas variables no solo ayuda a entender los procesos internos que explican estos comportamientos, sino que también permite proponer estrategias de prevención y acompañamiento. La presente investigación tiene como propósito aportar al conocimiento científico en este campo, contribuyendo a la detección temprana de factores de riesgo y al diseño de programas que promuevan el bienestar emocional de los jóvenes.

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, en el que se

describe la situación actual de las autolesiones y de la impulsividad, así como la importancia de investigarlas. Allí se presenta la formulación del problema central, se definen los objetivos de la investigación y se explica por qué el estudio es pertinente tanto en el ámbito académico como social.

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se profundiza en los conceptos centrales de la investigación. En este apartado se revisan las principales teorías y modelos explicativos sobre autolesiones e impulsividad, además de los estudios previos que evidencian la relación entre ambas variables. Este análisis permite establecer un sustento sólido para interpretar posteriormente los resultados obtenidos.

El tercer capítulo presenta la hipótesis de la investigación, tanto la general como las específicas. Además, se definen de manera precisa las variables, señalando sus dimensiones e indicadores, lo que permite delimitar con claridad cómo serán medidas en la población de estudio.

En el cuarto capítulo se expone la metodología utilizada. Se detalla el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra seleccionada, así como los instrumentos de recolección de datos. También se especifican los procedimientos seguidos y las consideraciones éticas que aseguran la validez y la confiabilidad del estudio.

El quinto capítulo contiene los resultados, organizados a partir de los datos obtenidos y presentados de manera clara en tablas, gráficos y análisis estadísticos, de modo que respondan directamente a los objetivos planteados en la investigación.

En el sexto capítulo se desarrolla la discusión, donde los resultados se interpretan y se comparan con lo planteado en la hipótesis y con las investigaciones previas revisadas. También las conclusiones que recogen los hallazgos más importantes de la investigación. Estas conclusiones se vinculan directamente con los objetivos planteados al inicio del estudio. Asimismo, se incluyen recomendaciones tanto para la práctica profesional en

psicología clínica y educativa como para futuros trabajos de investigación que busquen profundizar en la relación entre autolesiones e impulsividad.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. Planteamiento del Problema

Recientemente, se están atravesando diversas problemáticas en el grupo etario adolescente, las mismas que se convierten en una problemática mundial, sin importar la región. Una de estas problemáticas son las conductas de riesgo que se expresan de múltiples formas. Un ejemplo de ellas son las autolesiones (Hawton, 2000), que presentan una prevalencia entre un 30 % y un 40 % en poblaciones clínicas adolescentes, quienes frecuentemente llegan a la hospitalización (Briere et al., 2011, como se citó en Villarroel et al., 2013). Es así como se advierte una problemática presente en distintos países del mundo; a ella se le consigna en una primera instancia las conductas autolesivas. En países como Australia se ha reportado que el 8.1 % de la población se ha autolesionado alguna vez en su vida (Taylor et al., 2011).

En Nueva York, Eckart (2021), llevo a cabo una investigación en alianza con la Universidad de New York y Universidad de Washington, en una muestra representativa de la ciudad, donde encontró que un gran porcentaje de adolescentes ha tenido pensamientos autolesivos, estos estudiantes pertenecían a instituciones educativas del estado; posteriormente señalaron específicamente que un 3 % presentaba haber intentado acabar con su vida sin que este haya sido planificado, un 38 % indicó que había planificado acabar con su vida, sin la necesidad de llegar a realizar una conducta asociada a la misma; mientras que un 35 % detalló haber premeditado, planificado y haber realizado actos para intentar finalizar con su vida, según los datos reportados por la Fundación ANAR (Atención de Niños y Adolescentes en Riesgo), en comparación con los dos años anteriores. Dörr et al. (2022) señalan que la prevalencia de autolesiones en adolescentes a nivel mundial oscila entre el 13 % y el 45 %, con un inicio generalmente

entre los 10 y 15 años. Dichos datos revelan cómo las conductas autolesivas se encuentran presentes en un sector representativo de Estados Unidos, señalando una de las múltiples problemáticas que se encuentran en dicho país.

Sin embargo, la realidad problemática de América es diversa, donde el país con mayor índice de práctica de autolesiones es México, en donde se han llevado a cabo diversos estudios con respecto a esta problemática. Entre ellos encontramos la investigación realizada por la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual señala que las autolesiones se practican más en estudiantes mujeres (21.26 %) que en varones (7.77 %), cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años (Meza et al., 2019). Otro estudio realizado en el mismo país, con respecto a la resiliencia de los estudiantes, encontró que existía mayor resiliencia en el sexo femenino; sin embargo, esta se debilitaba frente al incremento de las exigencias del entorno, aumentando el riesgo de malestar emocional (Rodríguez y Cotonieto, 2022). Mientras que en Chile esta situación se refleja en un porcentaje mayor al 10 % de ingresos hospitalarios vinculados a traumatismos, envenenamientos y causas externas en adolescentes de 10 a 19 años (MINSAL, 2013). Por otro lado, Tabares et al. (2020), quienes encontraron en Medellín, en un trabajo con adolescentes jóvenes, que un 77.7 % no presentaba características de impulsividad, mientras que un 22.3 % presentaba características de impulsividad bien marcadas. Bajo estos datos se identifica que las autolesiones están presentes en países de América del Sur en muchos casos; cuando no es detectada y trabajada, tiene desenlaces fatales.

En la realidad Peruana el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (2022), indica que durante los años 2016 y 2021, del total de la estadística que se refiere a las conductas autolesivas del Perú, un 71.5 % pertenecían a las edades correspondientes a los 15-34 años de edad; aumentando que la generalidad de casuística en el género femenino correspondía a los 15-19 años resaltando una prevalencia

en el género femenino, mientras que en varones la mayor tasa fue entre 20-34 años. De manera general, estas conductas autolesivas representan el 69 %, mientras que una tasa de un 47.3 % pertenece a la vida joven; es decir, que gran parte de la problemática nacional en torno a las autolesiones se encuentra en los adolescentes.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud Mental (2021) encontró que un 23.2 % de adolescentes presentó problemas emocionales y conductuales; en contraparte, el 76.8 % no presentó ninguna de las señaladas. Dicha situación destaca que existe una cantidad de población adolescente que se encuentra en estado de riesgo por no tener las habilidades necesarias para gestionar sus problemas emocionales, pudiendo conducirles a realizar actos en su contra. Mientras que, en los niños, el 84 % presentaba problemas emocionales y de comportamientos; sin embargo, no recibieron una atención oportuna. De los niños que recibieron atención, el 4.8 % fue atendido en una clínica privada, el 2.8 % en un consultorio privado y solo un 2.6 % recibió atención en un establecimiento de salud del Estado. Estas cifras develan la problemática nacional donde no se puede acceder a los profesionales especializados para poder resolver las diversas problemáticas mentales, convirtiéndose en un factor de riesgo para la urbe infante y adolescente, ubicándolos dentro de una posición riesgosa; de igual manera, despiertan la necesidad inmediata de poder realizar la detección a priori de casos de adolescentes que presenten problemas emocionales, los mismos que se pueden asociar con la impulsividad y problemas de conductas que se reflejen en conductas autolesivas. Esto permitirá trazar planes y estrategias que permitan evitar las consecuencias negativas de las mismas.

Continuando con la revisión académica nacional, en la región Tacna, García (2023) llevó a cabo una investigación referida a las conductas autolesivas, donde estableció que el 19.4 % estaba marcado en el género femenino, mientras que en el masculino, en un 21.9 %, existía una diferencia mínima en el género masculino, que

disipa otros hallazgos nacionales. Estos datos reflejan que en la problemática peruana no es tan determinante el género para indicar la presencia de conductas autolesivas, sino que atañe a ambos géneros por igual y que es un factor de riesgo actual para los adolescentes en el país. A manera de complemento, Barrientos (2024), en un estudio sobre la impulsividad en adolescentes, reveló que una mayoría del 49 % presentaba niveles altos de impulsividad, mientras que el 26,1 % mostraba niveles bajos y otro 26,1 %, niveles moderados. En tal sentido, se identifica que los problemas de impulsividad en adolescentes se encuentran en niveles elevados y que requieren de una intervención oportuna en la que se les pueda enseñar a gestionar sus emociones a fin de evitar acciones impulsivas que puedan ocasionar daño a otras personas o a sí mismas.

Finalmente, en la región Cusco, se hizo una investigación donde un 18.8 % de adolescentes presentan una tendencia al suicidio y el 6.82 %, un riesgo alto de conductas autolesivas (Sánchez, 2020). Dichos datos reflejan que los adolescentes cusqueños con los que se trabajó están posicionados en una realidad riesgosa y se requiere determinar de manera específica y focalizada que otros adolescentes también presentan la misma problemática, a fin de poder trazar un plan de acción en beneficio de los estudiantes. Por su parte, Arredondo y Morales (2021) encontraron que, de una muestra representativa de adolescentes en Cusco, un 48.9 % presentaba características de impulsividad disfuncional. Dichos hallazgos permiten visualizar la problemática donde los adolescentes toman decisiones poco reflexivas sin premeditación y que estas pueden conducirlos a consecuencias negativas, impactando sobre su vida.

En la institución educativa en la que se planificó el estudio, los profesores han observado comportamientos preocupantes entre sus alumnos. Estos comportamientos incluyen desobediencia hacia los profesores, falta de respeto entre ellos, aislamiento social, expresiones faciales tristes y cortes autoinfligidos en sus brazos. Después de

examinar cuidadosamente los datos y considerar el impacto de las conductas autolesivas y la impulsividad, tanto a nivel internacional como en América Latina, se ha vuelto crucial investigar la conexión entre los cortes y la impulsividad en jóvenes dentro de una institución educativa en Quispicanchi, situada en Cusco, donde este problema es particularmente prevalente.

En la institución educativa ubicada en el distrito de Andahuaylillas (Quispicanchi, Cusco), los docentes y auxiliares, a través de sus observaciones diarias en las aulas y en el patio durante el recreo, han notado una serie de comportamientos y manifestaciones que, debido a su recurrencia e intensidad, son alarmantes y pueden estar asociados con autolesiones e impulsividad: afirman que los alumnos de secundaria han sido reportados en repetidas ocasiones por numerosos episodios de desobediencia y desafío a la autoridad, así como por enfrentamientos interpersonales casi permanentes en los que se producen burlas, provocaciones, faltas de respeto, agresiones y discusiones con un alto grado de agresividad y dificultad para detenerse, calmarse o pensar en las consecuencias de sus actos. También indicaron la presencia de conductas como golpes en las puertas, tirar cosas o empujar a sus compañeros de clase. Esto suele ocurrir a menudo y, por lo general, sin que se lamenten las acciones inmediatas o se justifiquen con frases poco reflexivas.

El personal de la institución educativa también observó fluctuaciones significativas en el estado de ánimo de los alumnos, caracterizadas por oscilaciones entre el desánimo y la irritabilidad, que se manifiestan en rostros inexpresivos, mirada perdida o desenfocada, llanto frecuente, aislamiento social, apatía pronunciada, disminución de la tolerancia a la frustración cuando se les reprende o se encuentran con errores académicos, y dificultades para verbalizar las emociones. Los indicadores de aislamiento social incluyen el alejamiento de los grupos habituales, la evitación del recreo o el comportamiento solitario, la incomodidad durante las interacciones con los compañeros,

la disminución de la participación en actividades y la tendencia a buscar áreas privadas o discretas durante períodos prolongados. En el ámbito académico, se observa un deterioro del rendimiento, la no entrega de tareas, el absentismo y las llegadas tardías, una disminución del interés por cursos o actividades que antes resultaban atractivos y una propensión a distraerse durante las clases, lo que puede indicar fatiga emocional o dificultades de concentración.

También algunos tutores han observado indicadores físicos de autolesiones, como cortes o marcas recurrentes en los brazos y antebrazos, el uso habitual de mangas largas o ropa que cubre la piel independientemente de las condiciones meteorológicas, la presencia de vendajes o apósitos sin una explicación coherente o acompañados de narrativas incoherentes, incomodidad cuando se les pregunta por las lesiones y esfuerzos por ocultarse durante las clases de educación física. Estos episodios suelen manifestarse tras conflictos con compañeros, medidas disciplinarias, disputas familiares o experiencias de humillación. En última instancia, el personal educativo indica que estos indicadores no solo influyen en la dinámica escolar, sino que también suscitan temores sobre la seguridad de los alumnos y la posibilidad de que se produzca una escalada hacia acciones más peligrosas. En consecuencia, dan prioridad a la comprensión de la correlación entre las lesiones autoinfligidas y la impulsividad dentro de este grupo demográfico para obtener pruebas que sirvan de base para medidas preventivas, protocolos de detección temprana y estrategias de apoyo coordinadas entre las escuelas, las familias y los servicios de apoyo locales en Andahuaylillas.

Resultando crucial establecer la correlación entre el comportamiento autolesivo y las tendencias impulsivas entre los adolescentes de una institución educativa ubicada en Quispicanchi. Esto permitirá identificar los principales requerimientos de este grupo demográfico y desarrollar estrategias de intervención orientadas a paliar los efectos

adversos de estos factores.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación entre las autolesiones y la impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025?

1.2.2. Problema específico

PE1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión adaptabilidad e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025?

PE2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión regulación afectiva e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025?

PE3. ¿Cuáles son los niveles de autolesiones en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025?

PE4. ¿Cuáles son los niveles de impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación entre las autolesiones e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

1.3.2. Objetivo específico

OE1. Determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de

Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

OE2. Determinar la relación entre la dimensión regulación afectiva e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

OE3. Establecer los niveles de autolesiones en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

OE4. Establecer los niveles de impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

1.4. Justificación de la investigación

Esta investigación se sustenta en la importancia que tendrá para brindar datos relevantes sobre la problemática específica de la muestra de estudio, que servirá para poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a su necesidad.

1.4.1. Justificación teórica

El marco teórico propuesto es resultado de un análisis sistemático realizado que permite identificar los aportes teóricos y los sustentos más importantes para ambas variables; además, el análisis estadístico resultante de esta investigación puede aportar datos sobre la disparidad actual en el corte e impulsividad en la región Cusco. Estos datos serán valiosos para futuras investigaciones como referencia o fuente de información para identificar los principales problemas que prevalecen en este sector específico de la población. Además, esto puede facilitar una comprensión revisada de este tema, particularmente dentro de este sector demográfico.

1.4.2. Justificación práctica

El estudio, al contribuir con resultados actualizados sobre la impulsividad y autolesiones en la muestra de adolescentes, permitirá que las principales autoridades de la institución consideren la necesidad de efectuar talleres o programas de intervención

especializados, con un enfoque cognitivo conductual, implementado en 8 sesiones que permite abordar la problemática de manera exitosa, de igual manera al ser una información pública los padres de familia podrán en primera instancia llevar a cabo un análisis sobre sus hijos y si identifican la necesidad poder acompañar acudiendo a un profesional especializado, de otro lado la UGEL, también podrá conocer la problemática de esta muestra y a través de su equipo de convivencia escolar pueda concertar una estrategia especializada con la dirección del colegio.

1.4.3. Justificación metodológica

Para desarrollar la investigación, se ciñe a los fundamentos del método científico, siguiendo un procedimiento estructurado, donde las herramientas que se han utilizado para medir cada variable cuentan con índices de confianza y validez ineludibles en su administración, y el procesamiento de la información se realiza mediante un software estadístico que permitirá conocer la existencia de una relación significativa. Considerando el aporte valioso de dicha asociación, podrá ser de gran utilidad para que otros investigadores puedan realizar comparaciones, considerando el presente como un antecedente de estudio de vital importancia.

1.4.4. Aporte social

La investigación sobre autolesiones e impulsividad en estudiantes de secundaria del distrito de Andahuaylillas, Cusco, es socialmente relevante porque aborda una problemática que afecta a adolescentes en una etapa de grandes cambios emocionales y sociales. En este contexto, factores como el acceso limitado a servicios de salud mental y la persistencia de estigmas dificultan que los jóvenes reciban la atención adecuada, lo que aumenta el riesgo de conductas autolesivas como forma de manejar la impulsividad. Este estudio busca visibilizar la problemática en el ámbito local y aportar evidencia que permita diseñar estrategias de prevención e intervención en las instituciones educativas.

Sus resultados pueden sensibilizar a docentes, familias y autoridades, fomentando un acompañamiento oportuno y promoviendo el bienestar emocional de los estudiantes.

1.5. Viabilidad

El estudio es viable debido a que se cuenta con la predisposición de los directores de la I.E. a fin de ejecutarse lo más pronto posible; de igual manera, se cuenta con la información teórica sobre las variables, al igual que los manuales de corrección de los instrumentos para su calificación y posterior análisis.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

Santana (2023), en su investigación titulada *Relación entre el insomnio y la impulsividad en estudiantes de Santo Domingo*, tuvo como objetivo conocer los niveles de impulsividad en los estudiantes. Se utilizó una metodología descriptiva correlacional con enfoque cuantitativo y se aplicó la Escala de Impulsividad de Plutchick a una muestra de 149 estudiantes. Los resultados mostraron que el 53.41 % presentó una elevada impulsividad, mientras que el 47.59 % tuvo niveles bajos de impulsividad. La investigación concluyó que existe una correlación directa entre el insomnio y la impulsividad ($p < .05$), indicando que, a medida que los estudiantes presentaban cuadros de insomnio, desarrollaban niveles elevados de impulsividad.

Esta investigación contribuye directamente a la línea de investigación de autolesiones e impulsividad, ya que evidencia la utilidad emocional del *cutting*, patrón que se suele asociar a respuestas impulsivas ante el malestar.

Jiménez (2023), en su estudio *Evaluación de autolesiones en adolescentes atendidos en Salud Mental Infanto-Juvenil*, tuvo como objetivo evaluar las conductas autolesivas en adolescentes atendidos en el ámbito de la salud mental. Con una metodología no experimental descriptiva, se utilizaron pruebas clínicas y corroboración con historias clínicas en una muestra de 40 adolescentes. Los resultados revelaron que el 55 % de los adolescentes presentó conductas autolesivas, de los cuales el 81.8 % se cortaba en brazos y muñecas, y el 71.4 % lo hacía con la finalidad de liberar o descargar preocupaciones emocionales. La investigación concluyó que las autolesiones están asociadas con sintomatología depresiva y pensamientos suicidas, destacando que los

adolescentes que presentan cutting están en un riesgo elevado de sufrir consecuencias graves.

Esta investigación apoya la línea de investigación de autolesiones e impulsividad, mostrando que el patrón de *cutting* es útil emocionalmente como forma de reacción impulsiva ante el malestar.

Zuñiga (2022), en su estudio *Autoconcepto e impulsividad en adolescentes del último año escolar*, se propuso describir los niveles de impulsividad en adolescentes de la última etapa escolar. La metodología fue descriptiva correlacional con un enfoque cuantitativo, utilizando la prueba AF5 y la Escala de Impulsividad de Barratt en una muestra de 33 estudiantes. Los resultados mostraron que el 79 % de los estudiantes presentó una impulsividad alta, y el 21 % presentó impulsividad media. La investigación concluyó que la impulsividad es una variable multidimensional en la adolescencia y que un autoconcepto no ideal puede generar molestias emocionales, lo que se refleja en elevados grados de impulsividad.

Este estudio resulta de gran valor, puesto que aborda una variable psicológica interna que puede volver a una persona vulnerable emocionalmente. Puesto que cuando el adolescente se evalúa de manera negativa, es más susceptible de experimentar dolor crónico y buscar soluciones inmediatas.

Zazueta (2022), en su investigación *Regulación emocional e impulsividad en estudiantes durante su proceso educativo*, tuvo como objetivo describir las dimensiones de la impulsividad en adolescentes durante su proceso educativo. Se utilizó una metodología descriptiva correlacional con enfoque cuantitativo, aplicando la Escala de Impulsividad de Barratt a una muestra de 120 adolescentes de nivel secundario en México. Los resultados mostraron que el 26.66 % presentó impulsividad cognitiva, el 33.33 % impulsividad motora, y el 40 % impulsividad no planeada. La conclusión destacó

que la impulsividad no planeada fue la más prevalente, señalando que esta dimensión de la impulsividad tiene una mayor presencia en los adolescentes.

Este estudio demuestra la prevalencia de la impulsividad, demostrando que la impulsividad no premeditada se asocia sobre todo con autolesiones que se producen en el momento, en respuesta a emociones intensas.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Pary y Sánchez (2022), en su investigación *Desregulación emocional e impulsividad asociadas a las autolesiones sin intención suicida en adolescentes de Lima Metropolitana*, tuvieron como objetivo analizar la relación entre las autolesiones y la impulsividad. La investigación siguió un diseño no experimental correlacional-explicativo con una muestra de 624 adolescentes, a quienes se les aplicaron la escala DERS-SF, la escala ECI-R y la cédula de autolesiones según DSM-5. Los resultados mostraron que la impulsividad se relaciona positivamente con las autolesiones ($p=0.05$), encontrando que el 45 % de los estudiantes presentaban un nivel bajo de impulsividad, el 43.3 % un nivel medio y el 10.9 % un nivel alto. En cuanto a las autolesiones, el 38.1 % presentó un grado medio, el 32.2 % un grado bajo y el 29.6 % un grado alto. La conclusión indica que existe una relación directa entre la impulsividad y las autolesiones en adolescentes.

Este estudio incorpora, además de la impulsividad, la desregulación emocional como variable explicativa, en consonancia con la conceptualización actual de las autolesiones como una conducta que surge para regular emociones intensas.

Gutierrez y Yáñez (2022), en su investigación *Exposición a la violencia y la conducta autolesiva en estudiantes de secundaria del distrito de Nuevo Chimbote, 2023*, se propusieron describir la práctica del cutting en estudiantes de secundaria. Utilizaron un diseño descriptivo correlacional con una muestra de 64 adolescentes a los que se les

aplicó la Cédula de Autolesiones CAL. Los resultados revelaron que el 40,6 % de los estudiantes de 14 años practicaron *cutting*, seguido del 21,8 % de los adolescentes de 15 años. La conclusión fue que un 40 % de los estudiantes llevaron a cabo acciones relacionadas con las autolesiones.

Esta investigación evidencia la existencia real de autolesiones en tempranas edades de secundaria, lo que sirve para dimensionar el problema y situarlo en periodos críticos del desarrollo.

Mendoza (2022), en su estudio *Impulsividad en estudiantes del nivel secundario de una I.E. del distrito de San José, 2022*, tuvo como objetivo describir los niveles de impulsividad en una muestra de 215 alumnos. Se utilizó un diseño no experimental correlacional y la Escala de Impulsividad de Barratt para la evaluación. Los resultados mostraron que, en los varones, un 28 % presentó impulsividad baja, un 42 %, impulsividad media y un 30 %, impulsividad alta. En las mujeres, un 35 % presentó impulsividad baja, un 36 %, impulsividad media y un 29 %, impulsividad alta. La conclusión indica que en los varones predomina un nivel medio de impulsividad, lo mismo que en las mujeres.

Este estudio proporciona una línea base de cómo se distribuye la impulsividad en población escolar y permite verificar si en una muestra con autolesiones los niveles de impulsividad se dispersan hacia categorías más altas.

Espinoza y Vergara (2021), en su estudio *Conductas autolesivas en adolescentes de segundo y tercer año de secundaria de una Institución Educativa Supe, Barranca, 202*, tuvieron como objetivo encontrar el nivel de las conductas autolesivas en adolescentes de nivel secundario. Utilizaron un diseño no experimental descriptivo y de corte transversal con una muestra de 241 estudiantes, quienes se evaluaron con la Escala de Autolesión para Escolares. Los resultados indicaron que el 94.6 % presentó un grado bajo de

autolesiones, mientras que el 5.4 % presentó un nivel promedio. En las dimensiones, los niveles bajos fueron: influencia interpersonal (97.5 %), autocastigo (98.8 %), antisuicidio (93.4 %), sexual (99.6 %), disociación (86.7 %) y límite interpersonal (91.7 %). Los niveles promedios fueron en regulación de afecto (29.9 %), disociación (11.2 %) y límite interpersonal (8.3 %). La conclusión afirma que no se encontraron niveles altos de autolesiones.

Esta investigación demuestra que algunas dimensiones como regulación afectiva presentan porcentajes más elevados en promedio, lo que indica puntos vulnerables en los que se pueden desarrollar conductas autolesivas si aumentan los factores de riesgo.

Huamani (2020), en su investigación *Impulsividad y autolesión en adolescentes de dos instituciones educativas públicas del distrito de Carmen del a Legua Reynoso-Callao, 2019*, buscó identificar la asociación entre impulsividad y autolesión en una muestra de 270 estudiantes. La investigación adoptó un diseño no experimental descriptivo correlacional y se utilizó el Cuestionario de Impulsividad de Barratt y la escala de autolesión de Shager. Los resultados mostraron una asociación directa y significativa entre ambas variables ($r=0.954^{**}$ y $p=.000$). En cuanto a la impulsividad, el 47.4 % presentó un nivel medio, el 42.6 %, un nivel alto y el 10 %, un nivel bajo. Para las autolesiones, el 55.2 % presentó un nivel medio, el 31.9 % un nivel bajo y el 13 % un nivel alto. La conclusión señala que existe una relación significativa entre la impulsividad y las autolesiones.

Este estudio brinda datos consolidados que permiten sustentar y respaldar la asociación entre autolesiones e impulsividad porque estadísticamente se correlaciona muy fuerte, lo que apoya la hipótesis de asociación del estudio.

2.1.3. Antecedentes locales

Paucar y Yupanqui (2024) llevaron a cabo un estudio titulado *Autolesiones e*

ideación suicida en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública de Cusco, 2023. El objetivo de la investigación fue determinar el nexo entre las autolesiones y la ideación suicida en adolescentes. Utilizaron una metodología descriptiva correlacional con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 150 estudiantes, a quienes se les aplicaron la Cédula de Autolesiones CAL y la Escala de Ideación Suicida de Beck. Los resultados indicaron que el 37,3 % de los estudiantes no mostraron signos de autolesión, el 30,7 % experimentó autolesiones leves, el 19,3 % presentó autolesiones moderadas y el 12,7 % enfrentó autolesiones graves. La investigación concluyó que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre las autolesiones y la ideación suicida en adolescentes ($p < .000$ y $r = .769$), sugiriendo que las autolesiones son un indicador de riesgo elevado para la ideación suicida, lo que hace que no deban verse solo como conductas aisladas, sino como señales de alerta.

Este estudio evidencia que las autolesiones pueden ser un indicador temprano de riesgo asociado a pensamientos suicidas.

Bustinza (2022) desarrolló un estudio sobre la impulsividad en estudiantes de una institución educativa de Cusco, titulado *Análisis de la impulsividad en los estudiantes de una institución educativa de Cusco*. El objetivo del estudio fue detallar la variable impulsividad en los estudiantes de la muestra. Este estudio adoptó un diseño correlacional-descriptivo con enfoque cuantitativo, en el cual se utilizó la prueba de percepción de Semejanzas y Diferencias. La muestra estuvo compuesta por 243 estudiantes. Los resultados mostraron que el 81,9 % de los estudiantes presentaba un control de impulsividad en un estado regular. La conclusión del estudio indicó que, aunque no hay un déficit extremo en la autorregulación, los estudiantes presentan dificultades parciales para regular sus reacciones y conductas ante diversas situaciones.

Esto sugiere que la falta de control óptimo de la impulsividad puede incrementar la vulnerabilidad de los adolescentes a manifestar conductas de riesgo, como las autolesiones.

Esta investigación demuestra que en Cusco existen estudiantes que se encuentran en un nivel “regular” de control impulsivo, lo que vendría a ser una zona de riesgo silenciosa: no es un déficit grave, pero sí una autorregulación insuficiente ante situaciones emocionales o sociales.

Zuñiga (2024) llevó a cabo un estudio titulado *Impulsividad y uso problemático de la pornografía en estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de una institución educativa del distrito de Cusco, 2023*. El objetivo de la investigación fue conocer el vínculo entre la impulsividad y el uso problemático de la pornografía en adolescentes. La investigación adoptó un diseño descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo y se aplicaron la Escala de Impulsividad de Barratt y la Escala de Uso Problemático de Pornografía a una muestra de 162 estudiantes. Los resultados revelaron que el 70,1 % de los estudiantes presentaba niveles medios de impulsividad, el 18,3 %, niveles bajos y el 11,6 %, niveles altos. El estudio concluyó que existe una relación débil, pero estadísticamente significativa, entre la impulsividad y el uso problemático de la pornografía, con un coeficiente de correlación de $r = .329^{**}$ y un nivel de significancia de $p = .001 (<.05)$. Esto indica que, aunque la relación no es fuerte, los adolescentes con mayores niveles de impulsividad tienen una mayor probabilidad de involucrarse en un consumo problemático de pornografía.

Este estudio evidencia que la impulsividad se asocia con conductas de riesgo y patrones de consumo problemáticos, lo que indica una búsqueda de gratificación o alivio inmediato del malestar.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Autolesión

2.2.1.1. Definición conceptual

Las conductas autolesivas representan hoy en día un serio problema de salud pública, especialmente en la población adolescente. Desde mediados de los años sesenta se observa un aumento en su prevalencia, aunque durante varias décadas la investigación fue escasa. De hecho, recién en los años noventa comenzaron a desarrollarse estudios más sistemáticos. En países como Inglaterra y Gales, por ejemplo, se estima que alrededor de 25.000 adolescentes acuden cada año a los servicios de urgencias médicas debido a conductas autolesivas (Hawton et al., 2000).

A pesar de contar con cierta información sobre la frecuencia de estas conductas, aún se sabe poco acerca de las razones específicas que llevan a los adolescentes a autolesionarse. Gran parte de los datos provienen de registros hospitalarios, lo que limita la visión real del problema, pues muchos jóvenes nunca llegan a buscar atención médica. Esto genera estadísticas parciales que no reflejan la verdadera magnitud del fenómeno. Además, persisten múltiples ideas erróneas: se tiende a pensar que un adolescente se autolesiona solo para llamar la atención de sus padres o que la práctica no siempre implica gravedad clínica. No obstante, la seriedad del problema puede relacionarse directamente con la intensidad del daño físico provocado.

Durante mucho tiempo, la ausencia de criterios diagnósticos claros complicó el abordaje clínico. Tanto el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) como la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, 1992) no incluían categorías específicas para las autolesiones, lo que llevó al uso de múltiples denominaciones y definiciones. En este contexto, la literatura propuso interpretaciones diversas. Para la Mental Health Foundation (2000), se trata de actos deliberados de daño al cuerpo como cortes,

quemaduras o consumo de sustancias; mientras que Young Minds (2003) las describe como un mecanismo de afrontamiento frente a emociones intensas y difíciles de manejar, expresándose a través de conductas como la dermatilomanía, la tricotilomanía o la automedicación.

La investigación reciente ha permitido precisar el concepto. Klonsky et al. (2014) definen la autolesión como la acción de dañar intencional y directamente el propio tejido corporal sin la intención de provocar la muerte, y que además no es culturalmente aceptada. Esta definición coincide con la propuesta de Arrieta (2020), quien considera autolesión todo comportamiento deliberado, autónomo y directo que cause un daño inmediato en la superficie corporal, como cortes o hematomas, siempre que no exista intención suicida. Según esta autora, términos como “deliberada”, “autoinfligida” y “directa” son clave para diferenciar las autolesiones de accidentes o de otras conductas que generan daño como consecuencia secundaria, por ejemplo, el abuso de alcohol o los trastornos alimentarios (Klonsky, 2005).

En la práctica clínica, esta diferenciación es fundamental. Tal como señala Arrieta (2020), no todas las conductas dañinas para el cuerpo pueden catalogarse como autolesiones, ya que muchas de ellas tienen un origen distinto al acto de hacerse daño de manera consciente. El DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) refuerza esta visión al definir la autolesión no suicida como daño directo sobre el tejido corporal, con ausencia de intención de morir. De manera complementaria, McAllister (2003) y Allen (2007) destacan que la motivación principal de la autolesión suele estar vinculada a la regulación de emociones intensas o al alivio del malestar psicológico, y que la ausencia de respaldo cultural es un criterio indispensable para distinguirla de rituales o prácticas aceptadas socialmente.

2.2.1.2. Ciclo de la autolesión

Los ciclos de las conductas autolesivas pueden entenderse como un proceso relacional entre la emoción intensa, la regulación disfuncional y la conducta de daño, conformando una especie de bucle que refuerza la autolesión con el tiempo (Nock, 2010). En ese sentido, pueden distinguirse las siguientes fases adaptadas:

- a) **Emociones dolorosas:** El ciclo inicia con emociones intensas y difíciles de manejar, como tristeza, ansiedad, vacío o enojo. Estas sensaciones negativas se acumulan, generando una tensión emocional y física que la persona percibe como insoportable (Nock, 2010).
- b) **Inicio de la tensión emocional y física:** La acumulación de estas emociones provoca angustia y estrés que impactan en el cuerpo y en los procesos mentales, incrementando la sensación de malestar y descontrol (You, Ren, Zhang, Wu & Lin, 2018).
- c) **Dificultad para expresar y manejar el dolor emocional:** Al no contar con estrategias adecuadas para expresar su malestar, la persona siente que no puede comunicar lo que le pasa, lo que aumenta la impulsividad y agrava el sufrimiento (You et al., 2018).
- d) **Incremento del estrés y sufrimiento:** La incapacidad de expresar el dolor emocional hace que la tensión se intensifique y el estrés emocional aumente, reforzando la sensación de desesperanza (Apicella et al., 2025).
- e) **Necesidad de frenar la tormenta emocional:** Ante esta “tormenta” interna, la persona busca detenerla de algún modo, ya que siente angustia, soledad y miedo abrumadores. Esto puede llevarla a contemplar la autolesión como una forma de calmarse (Nock, 2010; Apicella et al., 2025).
- f) **Desconexión momentánea:** Con el fin de evitar el dolor emocional, se desarrolla

una inclinación a desconectarse de la situación. Esta desconexión prepara el terreno para realizar la autolesión como escape temporal (Apicella et al., 2025).

g) Autolesión: En esta fase, la persona elige de manera deliberada el método, el momento y la zona del cuerpo para hacerse daño. Lo hace con control y discreción para que las heridas no sean graves ni visibles, minimizando así la necesidad de hospitalización o que otros lo noten (Nock, 2010).

h) Alivio: Después de autolesionarse, aparece una sensación de liberación y calma temporal. El dolor físico parece disminuir la tensión emocional, lo que devuelve al individuo a un estado más sereno y le permite retomar su rutina diaria, aunque el ciclo puede repetirse (Nock, 2010; Apicella et al., 2025).

2.2.1.3. Características sintomáticas definitorias

a) Daño físico:

Las personas que se autolesionan suelen provocarse heridas en la piel de distintas maneras: cortes con cuchillos u objetos punzantes, raspaduras con materiales ásperos como madera, quemaduras con cigarrillos o incluso lesiones ocasionadas por el uso de sustancias químicas, como productos de limpieza. También es común la introducción de objetos dañinos en orificios del cuerpo, el retraso intencional en la cicatrización de heridas o la perforación de la piel con distintos instrumentos (Scilleta, 2009).

b) Intencionalidad

Este tipo de conductas no ocurren por accidente. Quienes se autolesionan lo hacen de manera voluntaria y consciente, después de reflexionar, aunque sea de forma breve, sobre el acto. Es decir, son plenamente conscientes de lo que hacen y del daño que se provocan (Walsh, 2014).

c) Baja letalidad:

Las lesiones que se producen, aunque dolorosas y dañinas, no ponen en riesgo

inmediato la vida. La intención detrás de estos actos no es acabar con la propia existencia, lo que diferencia claramente a las autolesiones de un intento de suicidio (Nixon & Heath, 2008).

d) Socialmente inaceptable:

Aunque algunos adolescentes pueden iniciarse en estas conductas por influencia de sus pares o por la repetición de lo que observan en otros, cada persona suele atribuirle un significado muy personal. Sin embargo, no se trata de un comportamiento aceptado socialmente ni de una práctica orientada únicamente a la aprobación o integración en un grupo, sino de una manifestación individual con un trasfondo más complejo (Quintanilla, 2004).

2.2.1.4. Factores determinantes de la conducta autolesiva

Según Flores, Cancino y Figueroa (2018), los factores determinantes son:

a) Factores biológicos

Una reducción de los neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, que ayudan al control de las emociones facilitando la transmisión de impulsos entre ciertos nervios de la región del cerebro que tiene como función estabilizar la agresión junto a la conducta impulsiva. Los neurotransmisores opioides son reconocidos por su papel en la regulación de las emociones y la inhibición del dolor, lo que provoca efectos placenteros. Este fenómeno lleva a los individuos a autolesionarse, lo que desencadena la expulsión de neurotransmisores, produciendo un impacto de calma que alivia y libera la molestia.

b) Factores psicológicos

El individuo se autolesiona como medio para aliviar una intensa angustia mental, infligirse un castigo y hacer patente su angustia a los demás. La combinación de una reticencia a expresar abiertamente las emociones y unas capacidades cognitivas limitadas lleva a los individuos a desarrollar una autopercepción negativa, una baja autoestima y a

recurrir a la autolesión como medio para hacer frente a sus desafíos. Este comportamiento aparentemente proporciona un alivio temporal de la tensión e induce una sensación de relajación mental. Existe una estrecha relación entre los comportamientos autolesivos y la experiencia de un trauma emocional, que se define como una alteración del desarrollo normal en la infancia. Este trauma puede incluir agresiones sexuales y/o físicas, negligencia emocional y problemas en la familia en proceso entre la niñez y la juventud (De la Fuente, 2018).

c) Factores sociales

Distintas condiciones sociales logran ejercer influencia sobre el comportamiento autolesivo; entre ellas, las prácticas infantiles suelen contribuir en la inclinación a desarrollar hábitos autolesivos, pero que no tienen el objetivo de acabar con su vida. Ulloa et al. (2013) ofrecen la siguiente enumeración:

- Observar o participar en actos de maltrato físico y agresión.
- Experimentar abusos sexuales y/o ver abusos sexuales perpetrados por un familiar.
- Fallecimiento de un familiar directo o de una pareja sentimental.
- Sufrir angustia psicológica por haber sido objeto de acoso por parte de familiares o compañeros.
- Experimentar el abandono físico o emocional de uno o ambos progenitores.
- Experimentar los efectos de una enfermedad debilitante o tener un progenitor que padece una enfermedad debilitante.
- Padres dependientes del alcohol.
- Ser el resultado de una concepción no planificada y tomar conciencia de ello.
- La disolución del matrimonio de sus padres o disputas en su relación con ellos.
- Ser seleccionado como cuidador de un hermano menor o de un familiar enfermo.

2.2.1.5. Modelos teóricos

- Modelo de la regulación de los afectos

Considera que las autolesiones son una herramienta para aliviar emociones negativas graves e intensas. Psicológicamente, se cree que este comportamiento tiene su origen en haber crecido en un entorno invalidante, lo que provocó el desarrollo de mecanismos de afrontamiento ineficaces en la persona en cuestión (Mosquera, 2008).

- Modelo de disociación

Las afecciones dolorosas pueden inducir disociación, despersonalización o desrealización como respuesta a su vulnerabilidad inherente. Esta desafortunada realidad puede conducir a la aparición de prácticas autolesivas, que sirven al objetivo de restablecer una conexión con el sentido de uno mismo y la propiedad física a través de la experiencia del dolor, proporcionando así una sensación genuina y rejuvenecedora (Manca, 2011).

- Modelo de conducta suicida alternativa

El comportamiento autolesivo puede servir como válvula de escape para resistir el impulso de suicidarse. Proporciona un medio alternativo para expresar pensamientos y sentimientos perjudiciales sin arriesgarse directamente a morir (Gallegos, 2017).

- Modelo de la influencia interpersonal

Sirve para manipular las acciones, emociones y elecciones de personas importantes, sobre todo para evitar ser abandonado o para gozar de gran prestigio (Villaroel, 2013).

- Modelo del castigo

El comportamiento autolesivo se emplea como táctica para reforzar los efectos del castigo y la invalidación, hasta el punto de que se convierten en indispensables para moldear las conductas (Rodríguez y Guerrero, 2005).

- Modelo de búsqueda de sensaciones

La autolesión sirve a los individuos como medio para desarrollar emoción o regocijo, ya que los sentimientos extremos son necesarios para que se sientan conectados con la vida (Villarroel et al., 2013).

2.2.1.6. Dimensiones de las autolesiones

- Regulación de afecto

Según este paradigma, desarrollar habilidades para interactuar con los demás, así como el control emocional de un niño, se ve afectado por sus interacciones continuas con su cuidador principal (los padres). Esta idea postula que las actividades autolesivas en adolescentes y adultos sirven como medio para regular las emociones “negativas” y proporcionar una sensación de consuelo. Según Linehan (1993), los individuos se autolesionan como resultado de haber aprendido a hacer frente a sus crisis emocionales a través de este método. Según Andover y Morris (2014), la regulación del afecto debe entenderse como un ciclo donde la persona, consciente o inconscientemente, afecta a la intensidad, duración y experiencia subjetiva de las emociones.

- Autocastigo

El autocastigo nos permite centrarnos en las posibles razones de las acciones autolesivas. En su estudio, Flores et al. (2018) afirman que los individuos que se autolesionan lo hacen con la intención de aliviar su intenso malestar emocional. Esto puede implicar autocastigarse o hacer evidente su malestar ante los demás. Los jóvenes que se autolesionan afirman que cortarse les proporciona alivio de la tensión y una sensación de relajación mental. Según VelPalumbo et al. (2018), el autocastigo comienza cuando una persona se siente culpable y se utiliza como una forma de aliviar esta emoción. También ayuda a reducir el sufrimiento siguiendo un modelo aprendido de justicia y dolor en las interacciones sociales. Los participantes adquirieron la capacidad

de autocastigarse como resultado de las medidas disciplinarias empleadas por sus padres durante la infancia. Al autocastigarse, los sujetos reducen la necesidad de castigo externo, lo que facilita su proceso de socialización y promueve una sensación de calma tras el castigo.

2.2.1.7. Autolesión en la adolescencia

La adolescencia, que tiene lugar entre los 10 y los 19 años, es una fase crucial y distinta del desarrollo humano. Constituye un periodo de paso entre la niñez y la adultez, marcada por importantes transformaciones físicas, emocionales y sociales. Esta fase evolutiva presenta importantes peligros que impiden su progreso futuro, jugando el entorno social una influencia crucial (Iglesias, 2013; Papalia et al., 2012; Viejo & Ortega, 2015). Algunas de las situaciones de riesgo incluyen estar expuesto a la pobreza, el abuso y la violencia. Estos factores hacen que los individuos sean más susceptibles a problemas de salud mental, como trastornos emocionales y del comportamiento, trastornos alimentarios, quitarse la vida, distorsiones mentales, adicciones, libertinaje y autolesiones (OMS, 2018).

La autolesión no suicida (ANS) es una preocupación creciente para la salud mental de los adolescentes. En el presente, se está posicionando como una variable de interés para estudiosos clínicos y sociales debido a su creciente prevalencia entre los jóvenes de la comunidad (Mollá et al., 2015). Históricamente, se han relacionado con la existencia de determinados trastornos mentales, en particular el trastorno límite de la personalidad (TLP) o la conducta parasuicida (Villarroel et al., 2013). No obstante, su concepción actual es bien distinta. Estas conductas ya no se consideran infrecuentes, ni se limitan a individuos con problemas mentales (Jans et al., 2018).

En los artículos científicos, suele utilizarse diversos términos para describir las NSA, como autolesión, autolesión, autolesión intencionada, conducta autolesiva,

acciones parasuicidas, conductas autodestructivas, violencia autodirigida, autolesión, autolesión deliberada, y el término más reciente introducido en la V edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) (APA, 2013), “autolesión no suicida” (NSSI), que se considera nuevos rangos diagnósticos (Frías et al., 2012; González et al., 2016).

Diversos puntos de vista coinciden en su caracterización de estos comportamientos como acciones deliberadas de autolesión que resultan en daños no mortales, como cortarse, quemarse y golpearse (González et al., 2016). Sin embargo, divergen en cuanto a la intencionalidad subyacente y si estos actos son socialmente aceptados. Los estudiosos europeos abogan por una caracterización puramente conductual, independientemente de cualquier razón subyacente, como la presencia o ausencia de un objetivo suicida. También consideran que estos actos son culturalmente aceptables (Frías et al., 2012; Hawton et al., 2002).

Por otro lado, analistas de EE. UU. definen principalmente el comportamiento autolesivo como actos que no están culturalmente aceptados y que implican autolesiones sin intención de suicidio. Esta definición coincide con la proporcionada por el DSM-5 (Nock et al., 2006). Cabe destacar que el SNA se ha incluido recientemente en el DSM-5 como un diagnóstico novedoso, en concreto en la sección III del manual titulada “Medidas y modelos emergentes”, en la categoría de “Condiciones que necesitan más estudio” (APA, 2013). Por lo tanto, sugiriendo un avance significativo en el diagnóstico y comprensión de esta condición, su establecimiento como entidad diferenciada dependerá de que futuras ediciones del DSM confirmen su diagnóstico. Esta confirmación se llevará a cabo mediante la aplicación de estos criterios, al igual en situaciones clínicas y análisis científico (Vega et al., 2018).

Las autolesiones no suicidas se refieren a actos deliberados de autolesión en los

que los adolescentes infligen intencionadamente daño a su propio cuerpo sin intención de suicidarse (Fleta, 2017). En cuanto al género, algunas investigaciones han observado gran presencia en el género femenino (Gallegos, 2017; González et al., 2016; Jans et al., 2018), presentando promedio de 1,5 y 3 por encima de varones (Whitlock et al., 2006). Muchos jóvenes suelen realizar conductas autolesivas cortándose intencionadamente la piel con objetos punzantes, centrándose en zonas como las muñecas, los antebrazos, el vientre y las piernas. Además, también se han descrito como formas preferidas los golpes y las quemaduras. Las técnicas menos utilizadas incluían la inserción subcutánea de objetos, el frotamiento extensivo, los mordiscos, los tirones de pelo, los roces, los pellizcos y el envenenamiento.

En la mayoría de los casos se emplean estrategias distintas, y las mujeres muestran preferencia por formas que implican la percepción visual de sangre, como el corte y el arañazo fuerte; por otro lado, los varones suelen realizar actos como quemarse o golpearse a sí mismos (Manca et al., 2013; Sornberger et al., 2012; Villarroel et al., 2013). Dentro de las principales causas identificadas se encuentran la gestión emocional, el control impulsivo y la búsqueda de atención de su entorno (Flores-Soto et al., 2013). Respecto a la edad donde se origina este comportamiento, las investigaciones indican que suele comenzar entre los 10 y los 15 años. Sobre gran parte de jóvenes, el comportamiento autolesivo suele reducirse al llegar a los 17 años y suele resolverse por sí solo en la transición a la edad adulta temprana (Llul et al., 2017; Morán et al., 2012; Sánchez-Sánchez, 2018). En tal sentido, estos comportamientos han de ser poco comunes al pasar los treinta años (Herpertz, 1995; Villarroel et al., 2013).

El SSA ha surgido como un problema complejo que abarca varios aspectos sociales e individuales. Algunos de los factores de riesgo sociales incluyen un entorno familiar disfuncional, la violencia doméstica, la negligencia sobre las emociones, apego

inseguro, exigencias de amigos, violencia sexual, problemas con sus compañeros, los problemas matrimoniales y el estrés relacionado con la escuela (Fleta, 2017; Flores-Soto, 2016; Gratz et al., 2012; Ulloa et al., 2013; Villarroel et al., 2013). Las investigaciones detallan que las personas que experimentaron *bullying* a lo largo de su niñez y sus primeras experiencias de la juventud son más propensas a experimentar adicionalmente formas modernas de acoso escolar, tales como enviar chats o *ciberbullying*. Factores individuales: Temperamento desafiante, marcado por una mayor reactividad emocional, mayor sensibilidad, abundancia de emociones negativas difíciles de manejar, poca socialización e incremento de problemas en escenarios estresantes (Buss, 1995). Además, también se han identificado ciertas características de la personalidad, al igual que la impulsividad, la baja mentalización y una alta inclinación hacia la autoexigencia o el perfeccionismo (Sánchez, 2018).

2.2.2. Impulsividad

2.2.2.1. Definición de la impulsividad

La adolescencia es una etapa marcada por múltiples cambios y transformaciones, donde los individuos consolidan los hábitos adquiridos en la niñez y desarrollan nuevas capacidades, como la autorregulación de sus impulsos. Sin embargo, cuando un adolescente presenta conductas adictivas, como la dependencia al internet, se observa una disminución en su tolerancia al malestar, acompañada de una necesidad compulsiva de acceder a esta red. En este contexto, la impulsividad aparece como un rasgo psicológico estrechamente vinculado a la dificultad de controlar los propios actos (Papalia et al., 2012; Patton et al., 1995).

Uno de los primeros intentos por definir este concepto proviene de Barratt (1959), quien describió el control de impulsos como una disposición hacia respuestas rápidas ante distintos estímulos, ya sean externos (como situaciones del entorno) o internos (como

pensamientos o emociones). Estas reacciones, según el autor, no son el resultado de una reflexión consciente, sino de una respuesta automática.

Con el tiempo, la definición se fue enriqueciendo. Por ejemplo, Whiteside y Lynam (2001) señalaron que la impulsividad se expresa en acciones espontáneas e imprevistas que, al no estar planificadas, pueden generar consecuencias negativas para quien las presenta. Estos autores también resaltaron que la literatura científica ofrece diversas conceptualizaciones del término, algunas de ellas incluso contradictorias, lo que demuestra la complejidad del fenómeno.

Desde otra perspectiva, Liqueste (2015) considera que la impulsividad se caracteriza por dos elementos principales: la inmediatez de la acción y la ausencia de planificación. Según esta visión, un adolescente impulsivo actúa sin detenerse a pensar en las posibles consecuencias de sus actos, lo que puede llevar a conductas problemáticas, como la agresividad o la torpeza social.

En la misma línea, Eysenck (1959) explicó la impulsividad desde los rasgos de personalidad, vinculándola con la extraversión. Para este autor, las personas extrovertidas, al buscar constantemente estimulación externa, son más proclives a actuar de manera impulsiva. Esto se debe a la forma en que los impulsos nerviosos se procesan en el cerebro: en los extrovertidos llegan primero al mesencéfalo, favoreciendo una reacción inmediata; en los introvertidos, en cambio, llegan primero a la corteza cerebral, lo que les permite reflexionar antes de actuar.

Otros autores, como Moya (2017), ponen mayor énfasis en la dimensión social y educativa. Según su planteamiento, la impulsividad es, en gran medida, un comportamiento aprendido que surge en entornos donde no existen límites claros. En estos casos, los adolescentes no interiorizan normas ni restricciones, lo que facilita respuestas impulsivas ante situaciones cotidianas. Además, Moya subraya que la

impulsividad suele relacionarse con la ansiedad rasgo, es decir, con una predisposición a reaccionar espontáneamente en contextos de tensión.

Orellana (2017) amplía la mirada al describir la impulsividad como la realización de actos motores sin reflexión previa, lo cual se observa en diferentes etapas del desarrollo. En los adolescentes, este rasgo se combina con un componente cognitivo caracterizado por la distracción y los pensamientos intrusivos, que, junto con una regulación emocional deficiente, contribuyen a la aparición de conductas imprevistas.

Por su parte, Barbosa et al. (2015) destacan que la impulsividad está muy influida por las emociones. Una respuesta impulsiva puede llevar tanto a conductas constructivas como a comportamientos conflictivos. Sin embargo, en muchos adolescentes la falta de control y autodisciplina suele derivar en dificultades relacionales, sentimientos de frustración e incluso expresiones de violencia.

En términos generales, la impulsividad puede considerarse una característica de la personalidad vinculada a la supervivencia y a la autoconservación. No obstante, cuando se presenta de manera persistente y desadaptativa, puede convertirse en un rasgo problemático que afecte la vida social, emocional y académica del adolescente. Moeller et al. (2001) sintetizan este enfoque al definir la impulsividad como la tendencia a reaccionar rápida y espontáneamente, sin evaluar las repercusiones negativas que estas respuestas pueden tener tanto para la persona como para quienes la rodean.

2.2.2.2. Características de personas con impulsividad

Las personas que presentan un alto nivel de impulsividad suelen reaccionar de manera inmediata, sin detenerse a analizar las consecuencias de sus actos. Este tipo de comportamiento se caracteriza por una falta de consideración hacia el impacto que sus acciones pueden tener en los demás. Como resultado, quienes muestran baja tolerancia a la frustración encuentran dificultades para mantener la constancia en la consecución de

sus objetivos, ya que tienden a precipitarse en sus intentos y experimentan un intenso malestar emocional cuando no logran lo que se proponen (García, 2019).

Otro rasgo común en individuos con elevada impulsividad es la irritabilidad persistente. La literatura científica señala que, al tener un control limitado de sus impulsos, estas personas son más propensas a recurrir al consumo de sustancias legales e ilegales como una forma de regular sus emociones o disminuir la tensión interna. De esta manera, la impulsividad se convierte en un factor de vulnerabilidad que puede favorecer la aparición de conductas adictivas (Squillace & Picón, 2019).

En este sentido, es importante considerar los factores de riesgo que pueden potenciar la impulsividad. García (2018) destaca que existen múltiples condicionantes asociados al incremento de esta característica, aunque algunos son comunes a la mayoría de los individuos. Uno de ellos se relaciona con los cambios en la función cerebral, en especial en la regulación de neurotransmisores que influyen en la aparición o supresión de conductas disruptivas (Díaz & Moral, 2018).

Asimismo, el entorno social juega un papel determinante. Las figuras influyentes en la vida del adolescente, como familiares, amigos o referentes cercanos, impactan directamente en su comportamiento, pues el aprendizaje por imitación facilita la incorporación de patrones disfuncionales cuando estos modelos resultan inadecuados (Alcivar & Bejarano, 2020).

Finalmente, el ambiente familiar constituye otro elemento crucial. Vivir en hogares caracterizados por conflictos constantes, comunicación deficiente o dinámicas disfuncionales incrementa la probabilidad de desarrollar respuestas impulsivas. En estas condiciones, los adolescentes carecen de referentes positivos que les enseñen a regular sus emociones y a manejar de forma adecuada situaciones de frustración (More & Valdiviezo, 2022).

2.2.2.3. Origen de la impulsividad

La impulsividad no puede entenderse como un rasgo aislado, sino como el resultado de la interacción entre factores genéticos, cerebrales, neuroquímicos y ambientales. Investigaciones recientes muestran que esta característica de la personalidad tiene un carácter multifactorial y se relaciona tanto con procesos biológicos como con experiencias de aprendizaje y contexto social (Dalley et al., 2011; Verdejo-García et al., 2008).

- Factores genéticos

Los estudios en genética conductual han encontrado que existen predisposiciones hereditarias vinculadas a la impulsividad. Estas predisposiciones hacen que algunas personas tiendan a actuar sin reflexionar, a tomar decisiones rápidas y a involucrarse en conductas de riesgo. La investigación también ha mostrado que ciertos genes relacionados con el sistema dopaminérgico y serotoninérgico influyen directamente en el control de los impulsos (Verdejo-García et al., 2008).

- Aspectos cerebrales

A nivel neurológico, las investigaciones han identificado que la regulación del comportamiento impulsivo está estrechamente ligada a la corteza prefrontal, especialmente en las áreas orbitofrontal y ventromedial. Estas zonas son responsables de la planificación, la inhibición y el control de las conductas. Sin embargo, durante la adolescencia estas estructuras aún no han alcanzado su madurez completa, lo que explica la dificultad de muchos jóvenes para frenar sus impulsos (Peters & Büchel, 2011; Dalley et al., 2011).

- Factores neuroquímicos

Los neurotransmisores también cumplen un papel clave. Se ha encontrado que niveles bajos de serotonina aumentan la probabilidad de comportamientos impulsivos,

mientras que una mayor actividad dopaminérgica se relaciona con respuestas rápidas, particularmente en la ejecución de acciones motoras (Winstanley et al., 2006). Esto indica que los desequilibrios en los sistemas neuroquímicos pueden intensificar la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias.

- Procesos psicológicos y de aprendizaje

Más allá de la biología, la impulsividad también se explica desde modelos psicológicos. Teorías recientes destacan que no se trata únicamente de fallas en el control inhibitorio, sino de una combinación de factores cognitivos y emocionales, como la dificultad para demorar la gratificación, la intolerancia al malestar y la influencia de patrones aprendidos en la infancia (Hamilton et al., 2015; Amlung et al., 2016).

- Entorno social y familiar

El contexto en el que crece un individuo también juega un papel determinante. Estudios muestran que entornos familiares disfuncionales, la falta de límites en la crianza o la exposición a modelos impulsivos pueden potenciar esta característica de la personalidad. Asimismo, la presión de grupo y las experiencias sociales en la adolescencia pueden reforzar respuestas impulsivas y disminuir la capacidad de autorregulación (Beck et al., 2023).

En conjunto, estos hallazgos permiten entender que la impulsividad es un fenómeno complejo en el que convergen tanto factores internos: genéticos, cerebrales y neuroquímicos; como externos: sociales y familiares. Comprender su origen multidimensional no solo ayuda a explicar por qué algunas personas son más vulnerables a desarrollar conductas impulsivas, sino también a diseñar estrategias de prevención e intervención más efectivas.

2.2.2.4. Teorías de la impulsividad

Desde la psicología de la personalidad, la impulsividad ha sido abordada por

diferentes teorías que intentan explicar sus manifestaciones y matices. Una de las más influyentes es la teoría de Eysenck, quien planteó que la personalidad puede describirse a través de tres dimensiones principales: psicoticismo, extraversión y neuroticismo, conocidas en conjunto como el modelo PEN (Liquete, 2015).

- Teoría de Eysenck

En sus primeros trabajos, Eysenck vinculó la impulsividad con la extraversión, al considerar que las personas con este rasgo tendían a buscar mayor estimulación y, en consecuencia, mostraban conductas más rápidas y menos inhibidas. Con el paso del tiempo, la impulsividad fue reconocida como parte esencial de la extraversión, de modo que quienes presentan altos niveles de este rasgo suelen ser más propensos a actuar sin reflexionar demasiado.

- Teoría de Dickman

Por otro lado, la teoría de Dickman introdujo una visión más matizada de la impulsividad, diferenciando entre una forma funcional y otra disfuncional (Figueroa, 2013). La impulsividad funcional se asocia con conductas arriesgadas pero adaptativas, como tomar decisiones rápidas en situaciones que lo requieren, mostrando dinamismo y energía. En contraste, la impulsividad disfuncional se manifiesta en acciones descontroladas, realizadas sin considerar consecuencias, y que generalmente llevan a resultados negativos o poco productivos. De acuerdo con Squillace et al. (2011), la primera suele relacionarse con la extraversión, mientras que la segunda se vincula con rasgos de psicoticismo.

- Teoría de Barratt

En cuanto a la teoría de Barratt, esta define la impulsividad como la tendencia a actuar de manera automática y sin prever los efectos de la conducta (Barratt, 1959; 1985). A diferencia de la agresividad, que implica intencionalidad hacia el daño, la impulsividad

refleja más bien una dificultad en el control de la acción. Barratt propuso que este rasgo puede dividirse en tres dimensiones: la impulsividad cognitiva, que se observa cuando las decisiones se toman sin procesar suficiente información; la impulsividad motora, que se traduce en actuar de forma precipitada; y la impulsividad no planificada, que consiste en la incapacidad para anticipar los resultados de las acciones. Investigaciones posteriores respaldaron este modelo y demostraron que puntajes altos en la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS) se relacionan con dificultades en la autorregulación y con la presencia de trastornos como el abuso de sustancias, problemas de la conducta alimentaria o conductas autodestructivas (Moeller et al., 2001).

2.2.2.5. Dimensiones de la impulsividad

Barratt (1985) propuso que la impulsividad no debe entenderse como un rasgo único, sino como un fenómeno complejo que integra diferentes formas de comportamiento y pensamiento. Desde su perspectiva, este rasgo se organiza en tres dimensiones principales que permiten explicar cómo las personas actúan, piensan y se regulan en situaciones cotidianas. Esta visión fue clave para ampliar el estudio de la impulsividad y ha servido de base a posteriores investigaciones que coinciden en su carácter multidimensional (Patton et al., 1995; Evenden, 1999).

La primera de estas dimensiones es la impulsividad motora, entendida como la tendencia a actuar de manera rápida, sin detenerse a reflexionar demasiado. Esta muy influida por las emociones del momento y se traduce en respuestas inmediatas, lo que puede llevar a que la persona se precipite y le resulte difícil mantener la persistencia en actividades que requieren paciencia. Investigaciones posteriores han demostrado que esta forma de impulsividad está vinculada con la dificultad para inhibir conductas automáticas y con una mayor vulnerabilidad a problemas de autocontrol (Stanford et al., 2009; Cyders & Coskunpinar, 2011).

En segundo lugar, se encuentra la impulsividad cognitiva, relacionada con los procesos mentales que guían la toma de decisiones. Se trata de la predisposición a emitir juicios rápidos, con poco análisis, lo que a menudo genera respuestas poco adaptativas en situaciones que requieren reflexión o planificación. La evidencia en neuropsicología sugiere que este tipo de impulsividad está asociada con un menor control ejecutivo y con dificultades para sostener la atención de forma prolongada (Bechara, 2005; Hamilton et al., 2015).

Finalmente, Barratt señaló la existencia de la impulsividad no planificada, que se refleja en la dificultad para prever las consecuencias futuras de las propias acciones. Este tipo de impulsividad suele expresarse como una preferencia por obtener recompensas inmediatas en lugar de esperar beneficios a largo plazo. Como han señalado otros autores, esta característica se asocia con conductas de riesgo, problemas de organización y una regulación emocional limitada (Whiteside & Lynam, 2001; Sharma et al., 2014).

En resumen, las tres dimensiones propuestas por Barratt ofrecen una visión más amplia y detallada de la impulsividad. Lejos de ser un rasgo único, se manifiesta en distintas formas que abarcan tanto la acción como el pensamiento y la capacidad de planificar, aspectos que inciden de manera significativa en el desarrollo personal y en la adaptación social.

2.2.2.6. Factores predisponentes de la impulsividad en la adolescencia

Al examinar los componentes relacionada al origen de la impulsividad, se tienen en cuenta diversas variables biológicas, psicológicas y sociales. Una variable significativa es la edad, como demuestra un estudio realizado por Condor (2019). El estudio reveló que los niveles de impulsividad tienden a disminuir a medida que los adolescentes envejecen. Además, el estudio descubrió que la duración del tiempo pasado en centros de menores afecta sus rangos de impulsividad en jóvenes que presentan conductas delictivas.

Otros factores que se vinculan con el individuo son el tipo de delito realizado, la edad, su trabajo, situación, la ocupación, ingesta de drogas, el nivel de educación y la política educativa vigente (Poder Judicial del Perú, 2018).

Además, teniendo en cuenta una perspectiva evolutiva, podemos examinar las fluctuaciones hormonales durante la adolescencia, así como características de la personalidad como la intrepidez y las tendencias a buscar emociones. Estos factores contribuyen a decisiones impulsivas por parte de los jóvenes, posicionando en peligro su integridad y la de los demás que lo rodeen. La neurobiología indica que los comportamientos relacionados a la impulsividad suele relacionarse al circuito del placer, mecanismos de inhibición y mecanismo de recompensa, haciendo que los individuos no tengan en cuenta las repercusiones a largo plazo y den prioridad a la gratificación inmediata (Fernández, 2018). Entre las diversas características que favorecen su origen conductas delictivas, existen ciertos factores predisponentes. Entre ellos se encuentran la disfunción familiar, la socialización inadecuada por falta de una estructura familiar adecuada o una crianza negligente, así como las formas en las que se educa y los rasgos familiares (Segovia, 2017).

Al respecto de las condiciones del medio ambiente, las investigaciones han demostrado que observar y estar expuesto a modelos agresivos; de manera particular, en los primeros años de vida, influye considerablemente sobre el desarrollo de conductas impulsivas. Además, las relaciones negativas con los demás y su impacto en el comportamiento, sobre todo entre los adolescentes, aumentan en gran medida la probabilidad de conductas impulsivas. Es importante señalar que numerosos estudios sugieren que el contexto juega un papel crucial en el desarrollo y continuación de comportamientos violentos e impulsivos (Segovia, 2017). A ello se suman otras características como su estado económico, ausencia de valores y ambiente criminal

(Poder Judicial del Perú, 2011).

Según Betancourt y García (2015), residir en zonas con altos índices de criminalidad y tener padres divorciados resultaron ser los principales factores asociados con mayores niveles de impulsividad, lo cual está estrechamente relacionado con el desarrollo de conductas antisociales. Del mismo modo, puede deducirse que variables como la edad, el tipo de delito y la duración del internamiento están fuertemente correlacionadas con la impulsividad. Por ejemplo, dentro de un centro cerrado de menores en el norte de Perú, existe una diferencia notable en el control de las emociones y el control de sus decisiones sobre jóvenes de 15 y 16 años a diferencia de los de 18 y 19 años. También, cuando se trata de la infracción cometida, se identifica que los jóvenes que gozan de la libertad incondicional a raíz de agravios contra los bienes de otros, generalmente muestran niveles más altos de control de impulsos dentro de su vida cotidiana, en contraste con aquellos que cometen delitos en perjuicio de la libertad de los demás.

2.2.2.7. Consecuencias de la impulsividad en la adolescencia

- Dimensión Personal

Las consecuencias personales de un alto nivel de control de los impulsos pueden ser variadas y potencialmente graves, llegando incluso a provocar la muerte. La impulsividad perjudica considerablemente el funcionamiento del individuo afectando su salud de manera integral. Cuando los adolescentes con niveles significativos de control de impulsos corren un mayor riesgo de participar en conductas delictivas, que pueden provocar lesiones o la muerte. Además, los individuos con alta impulsividad pueden experimentar conflictos interpersonales, peleas y acoso escolar debido a su marcada falta de confianza en sí mismos (Medina et al., 2017).

Otras repercusiones son los embarazos no deseados, la madurez precoz y el

aumento de la actividad sexual, que acaban por desbaratar sus aspiraciones vitales. Además, la impulsividad se ha asociado con nuevos problemas de la personalidad, incluidos los trastornos de la alimentación, el trastorno antisocial de la personalidad, el TDAH, la bipolaridad, TOC (Martínez-Loredo et al., 2015). Finalmente, se asocia a diversas maneras de consumo de sustancias descontrolado, entre ellas la apuesta patológica, definida por una fuerte inclinación de realizar desafíos constantes y sin control en los que puede estar presente el consumo de drogas psicoactivas. Este comportamiento puede llevar incluso a la dependencia y a la experiencia de síntomas de abstinencia (Medina et al., 2017).

Esto se asocia con los hallazgos de Dávila (2020), donde afirma que las personas jóvenes impulsivos tienden a involucrarse en diversas infracciones y tienen problemas de conducta que están fuertemente asociados con la participación en actividades ilícitas. Del mismo modo, los adolescentes que tienen niveles elevados de impulsividad muestran frecuentes ausencias de la escuela, se involucran en el empleo de drogas que modifican la percepción, con alta relación de la transmisión de enfermedades sexuales.

- Dimensión Familiar

A nivel familiar, la presencia de un individuo muy impulsivo, sobre todo si es un adolescente, puede provocar un desorden en las conexiones interpersonales y un deterioro del clima familiar. En el entorno familiar, la ausencia de autorregulación emocional puede derivar en un problema importante en el que la ira se exprese de forma indiscriminada y se produzcan respuestas violentas, con las consiguientes consecuencias negativas (Segovia, 2017).

Asimismo, la impulsividad conlleva a comportamientos cerrados y preocupados en si mismo, en la que un adolescente se interesa en su manera de pensar, sus beneficios de forma inoportuna, arrasando con los derechos de otros, llegando a manipular a terceros.

Se conoce la existencia una asociación entre la agresión y la conducta impulsiva (Segovia, 2017).

Lo mencionado se relaciona con Villacorta y Contreras (2018), los mismos que indican que una familia tiene un rol trascendental en el desarrollo adecuado de un infante, asegurando que el funcionamiento de la familia es crucial para establecer patrones de conducta adecuados y llevar a cabo funciones esenciales para cada individuo. Se considera que una familia es funcional cuando satisface con éxito las necesidades de sus miembros, lo que redundará en su bienestar y crea un ambiente positivo en el hogar. Es crucial destacar que el funcionamiento de la familia es esencial para cada individuo. Una ausencia de comunicación apropiada entre los integrantes del grupo familiar puede repercutir negativamente en el comportamiento de los adolescentes. Pueden volverse violentos y tener relaciones inestables con los demás, lo que lleva a consecuencias más graves, como el comportamiento antisocial. Rojas (como se citó en Villacorta y Contreras, 2018) sostiene, que los adolescentes no son intrínsecamente agresivos, al contrario, es el entorno negativo el reforzador del comportamiento impulsivo.

- Dimensión Social

Desde un punto de vista sociológico, estas repercusiones son importantes, ya que pueden precipitar el enredo de los adolescentes en asuntos legales, engendrando así malestar social. Otra repercusión es el inadecuado nivel de estudios, que está estrechamente relacionado con la escasez de perspectivas de empleo. Esto conduce a una disminución del nivel de vida del individuo, ya que la probabilidad de obtener unos ingresos legítimos se vuelve casi inexistente. En consecuencia, los individuos recurren a medios alternativos como el robo, el fraude y otras actividades ilícitas para obtener beneficios. Los individuos con un alto grado de impulsividad son más propensos a participar en diversas formas de conducta antisocial, como robos con agravantes, tráfico

de drogas a pequeña escala, homicidios, creación de bandas criminales y delitos sexuales (Medina et al., 2017).

Ello concuerda con los datos de Bocanegra y Cabanillas (2020), donde detallan que en la actualidad la conducta impulsiva está erosionando las bases de la buena convivencia y los vínculos afectivos en nuestra sociedad. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (como se citó en Bocanegra & Cabanillas, 2020) señala que en Lima existen aproximadamente 370 bandas organizadas. Entre las provincias, Lambayeque y La Libertad tienen la mayor prevalencia, con 34 y 12 pandillas respectivamente. Es importante señalar que estas pandillas están conformadas principalmente por adolescentes entre 13 y 19 años.

2.2.2.8. Aspectos que influyen en la impulsividad de acuerdo con Barratt

- Influencia cognitiva

La impulsividad está vinculada al impacto cognitivo, ya que determina principalmente la manera de las personas para integrar datos, generan estrategias de resolución de problemas e interactúan con los demás de diversas maneras. La importancia de este ámbito reside en su aspecto cognitivo, ya que permite a los individuos evaluar y determinar las posibles reacciones que pueden ofrecer en respuesta a un reactivo.

- Influencias familiares o ambientales

Mata et al. (2013) afirman que el entorno familiar cumple un rol trascendental para la educación de los infantes. La exposición a un entorno familiar caracterizado por comportamientos impulsivos o violentos tendrá un impacto perjudicial en el crecimiento del niño, lo que provocará efectos negativos en su personalidad y desarrollo. Esto puede manifestarse como baja autoestima, dificultades para establecer relaciones interpersonales y bajo rendimiento académico. Del mismo modo, otros estudios han demostrado una mayor prevalencia de acciones impulsivas en niños procedentes de

hogares que experimentan dificultades continuas, cuidados parentales inadecuados y factores relacionados.

- Influencia biológica

Colombo et al. (2003) destacan la conexión entre las acciones impulsivas y el elemento biológico, a saber, el sistema nervioso central participa en la regulación emocional como consecuencia de la impulsividad. Además, neurotransmisores específicos se encargan de la regulación, inhibición o reducción de la actividad neuronal, ejerciendo así una influencia significativa en el comportamiento y la cognición.

2.3. Definición de términos básicos

Autolesiones: Klonsky et al. (2014), indican que es la conducta de ocasionar daño directamente sobre su propio tejido corporal, que no siempre tiene como fin acabar con la vida, y que culturalmente no es aceptada.

Regulación afectiva: Trata del ciclo donde la persona controla consciente o inconscientemente la intensidad, duración y experiencia subjetiva de sus emociones, tal y como argumentan Andover y Morris (2014).

Autocastigo: Según VelPalumbo et al. (2018), comienza con un sentimiento de culpa y se utiliza para aliviar esta emoción. También ayuda a aliviar el malestar siguiendo un modelo aprendido de justicia y dolor en el entorno social.

Impulsividad: Según la definición de Barratt (1959), es una tendencia caracterizada por una respuesta rápida ante la existencia de un estímulo.

Impulsividad cognitiva: Se refiere a la incapacidad para gestionar eficazmente la incursión de pensamientos y mantener una concentración sostenida. Implica dificultades para mantener el equilibrio cognitivo y la atención (Barratt, 1985).

Impulsividad motora: Se refiere a la tendencia a actuar de forma impulsiva y espontánea, impulsada por las emociones del momento. Implica una armonización de los

elementos motores y persistentes de la conducta (Barratt, 1985).

Impulsividad no planificada: Se refiere a una combinación de autocontrol y problemas cognitivos. Es un modelo que implica un procesamiento rápido de datos, que conlleva a decidir de forma prematura, sin premeditación y desalineados con el presente (Barratt, 1985).

CAPÍTULO III

HIPÓTESIS

3. Hipótesis

3.1. Hipótesis general

H0: No existe correlación entre la autolesión y la impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

Hg: Existe correlación entre la autolesión y la impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

3.2. Hipótesis específica

Hipótesis específica 1:

H0: No existe correlación entre la dimensión adaptabilidad e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

H1: Existe correlación entre la dimensión adaptabilidad e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

Hipótesis específica 2:

H0: No existe correlación entre la dimensión regulación afectiva e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

H2: Existe correlación entre la dimensión regulación afectiva e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025.

3.3. Matriz de operacionalización de las variables

Tabla 1

Matriz de operacionalización de las variables

Variable	Def. Conceptual	Def. Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de valoración
Autolesión	Es una acción, que consiste en aliviar de manera directa el malestar emocional, pero sin llevar a cabo el acto suicida (Cartolin y Palma, 2021).	Para medir la variable Autolesión se utilizará la Escala de Autolesiones de Cartolin y Palma.	Adaptabilidad	Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, roles y reglas.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	Nominal

			Regulación afectiva	Sensación de alivio por parte del individuo que carece de habilidades para regularse	16,17 y18	
Impulsividad	Pensamiento, emoción o comportamiento que conduce a consecuencias autodestructivas, interfiriendo de forma importante en la supervivencia y estabilidad de organismo (Patton, J., Stanford, M. y Barratt, E., 1995).	Para medir la variable Impulsividad se utilizará la Escala de Impulsividad de Biss 11.	Impulsividad cognitiva	Atención	5,9,11,20,28	Ordinal
				Inestabilidad cognitiva	6,24,26	
			Impulsividad motora	Motora	2,3,4,17,19,22,25	
				Perseverancia	16,21,23,30	
				Autocontrol	1,7,8,12,13,14	
			Impulsividad no planificada	Complejidad cognitiva	10,5,18,27,29	

Nota. Elaboración propia.

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1. Enfoque de la investigación

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, descrito por Herrera (2018), como un enfoque útil para investigar procesos, ideas y situaciones de manera exacta, permitiendo identificar características de modo numérico sobre una o más variables.

4.2. Método

La investigación hizo uso del método cuantitativo, puesto que utilizó la contrastación de la verdad o falsedad de las hipótesis a raíz de la constatación empírica, de los datos numéricos que se obtienen en la recopilación de información sometida a un tratamiento estadístico (Behar, 2008).

4.3. Tipo

Para el presente estudio se consideró una investigación de tipo básico, que, según Hernández et al. (2014), un estudio de tipo básico es una investigación inicial que se lleva a cabo para adquirir información general o de fondo sobre un tema, problema o fenómeno en particular. Este tipo de investigación se limita a recoger información elemental sin entrar en complejidades; se suele usar para dar un marco inicial para posteriores investigaciones más profundas o especializadas.

4.4. Alcance o nivel

Además, el estudio utilizó el alcance descriptivo correlacional para determinar la magnitud y la dirección de la asociación entre dos variables. Este enfoque tuvo como fin demostrar cómo los cambios en una variable se relaciona a la otra (Mousalli, 2015).

4.5. Diseño de la investigación

Se empleó un enfoque de estudio no experimental, lo que indica que el investigador no manipuló las variables. El estudio empleó un diseño transversal en el que

las variables se midieron en un momento determinado y se examinaron sin tener en cuenta los cambios en las unidades de investigación con el paso del tiempo (Alvares, 2020).

4.6. Población, muestra, selección de la muestra

4.6.1. Población

La población de estudio estuvo conformada por 230 estudiantes de primero a quinto año de secundaria de una institución educativa ubicada en el distrito de Andahuaylillas, dentro de la provincia de Quispicanchi-Cusco, en el año 2025. Tamayo y Tamayo (2005) definen la población como el conjunto completo de individuos u objetos que comparten un rasgo específico y son objeto de estudio.

Tabla 2

Población de la investigación

Grado	f	%
1	48	20.88%
2	43	18.69%
3	44	19.13%
4	49	21.30%
5	46	20%
Total	230	100%

Nota. Elaboración propia

Criterios de inclusión

- Estar matriculado en la institución educativa en el año 2025.
- Estar presente el día de la administración de los test psicológicos o instrumentos de investigación.
- Haber presentado el consentimiento informado y el asentimiento.

Criterios de exclusión

- No estar matriculado en la institución educativa en el año 2025.
- Ausentarse el día de la administración de los test psicológicos o instrumentos de investigación.
- No presentar el consentimiento informado y el asentimiento.

4.6.2. Muestra

La muestra de la investigación estuvo conformada por 230 estudiantes pertenecientes al primer, segundo, tercer, cuarto y quinto de secundaria de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas de la provincia de Quispicanchi-Cusco, 2025.

4.6.3. Selección de la muestra

Como afirman Hernández et al. (2014), una muestra censal implica recopilar información de todas las unidades que conforman el universo de estudio respecto a los aspectos o variables que se desean investigar. En este tipo de estudio, los datos se obtienen considerando la totalidad de la población, lo cual es posible debido a que esta es de tamaño reducido y finito.

Tabla 3

Género de la muestra

Género	F	%
Masculino	108	46.96%
Femenino	122	53.04%
Total	230	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 4*Edad de la muestra*

Edades	F	%
12 años	44	19.13%
13 años	44	19.13%
14 años	47	20.43%
15 años	42	18.26 %
16 años	46	20.00%
17 años	7	3.04%
Total	230	100%

Nota. Elaboración propia**Participantes**

Los participantes de la investigación pertenecieron a la institución educativa del distrito de Andahuaylillas de la provincia de Quispicanchi-Cusco, 2025, pertenecientes al nivel secundario.

4.7. Técnicas de recolección de datos

La investigación empleó la técnica de la encuesta, que, según la definición de Hernández (2010), es una técnica utilizada para recabar información y recoger opiniones de un grupo de personas en relación con un tema determinado. Para evaluar la variable de autolesión, se empleó la Escala de Autolesión, mientras que para medir la variable de impulsividad se utilizó la Escala de Impulsividad de Barrat.

Instrumentos: Ficha Técnica**Instrumento 1- Escala de autolesiones**

Ficha técnica:

Autor : Cartolin y Palma

Adaptación : Cartolin y Palma (2021), Callo-

Perú Objetivo	: Evaluar el nivel de autolesiones
Edad de aplicación	: 11 a 17 años
Ámbito	: Adolescentes
Forma de aplicación	: Individual-
Colectiva Ítems	: 18 ítems
Dimensiones	: Adaptación y regulación afectiva

Baremos

Para calificar e interpretar, el instrumento señala que primero se debe constatar que todos los ítems estén contestados y luego calificar cada uno del 1 al 5 (Nunca-Siempre); luego se suman por dimensión y, con los puntajes obtenidos, se ubica al evaluado en la categoría que le corresponda según baremos, identificando además la dimensión en la que obtuvo mayor puntaje.

Las puntuaciones en la Escala de Autolesiones de Cartolín y Palma (EACP, 2021), se determinan utilizando umbrales percentiles que clasifican el nivel de autolesiones en cuatro categorías: Clínicamente insignificante (percentiles 1 a 74), Riesgo moderado (percentiles 75 a 84), Problema considerable (percentiles 85 a 94) y Clínicamente significativo (percentiles 95 a 99). Los autores indican que los problemas de gravedad pueden evaluarse a partir del percentil 85 y que las puntuaciones a partir del percentil 95 significan una necesidad inmediata de asistencia profesional especializada, debido al grado de deterioro clínico que implican.

Validez y confiabilidad

Validez

La Escala de Autolesiones de Cartolín y Palma (EACP) demuestra su validez desde muchos ángulos. En primer lugar, utiliza la V de Aiken para informar sobre la validez del contenido, que se basa en los criterios de los jueces. El valor más bajo fue de

0,83 para la claridad, y los valores más altos fueron de 1,00 para la pertinencia y la relevancia. Esto significa que los ítems son aceptables para respaldar la idea de que representan con precisión el constructo que se evalúa (Cartolin y Palma, 2021)

Confiabilidad

La Escala de Autolesiones de Cartolín y Palma (EACP) demuestra consistencia interna, tal y como indica el alfa de Cronbach, alcanzando un valor de $\alpha = 0,90$ para la escala general, lo que significa un grado sustancial de homogeneidad entre los ítems. Las dimensiones también tienen coeficientes altos: Autopunición ($\alpha = 0,91$) y Control afectivo ($\alpha = 0,94$). Esto demuestra que cada dimensión mide su parte del constructo de autolesión de forma estable y consistente.

Instrumento 2 – Escala de impulsividad de Barratt

Ficha técnica:

Autor : Ernest Barratt, Jim Patton y Matthew

Stanford Adaptación : Flores (2018), en la ciudad de Lima-Perú

Objetivo : Evaluar los tipos de impulsividad en adolescentes y

adultos Edad de aplicación : 12 en adelante

Ámbito : Adolescentes y

adultos Forma de aplicación :

Individual y colectiva Ítems: 30 ítems

Dimensiones : Impulsividad motora, impulsividad cognitiva e impulsividad no planificada

Calificación

La puntuación de la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11), tal y como se explica en la adaptación de Flores (2018), comienza con una revisión del protocolo para asegurarse de que se ha realizado correctamente. Si la persona evaluada ha omitido ítems

o ha marcado más de una alternativa en la misma afirmación, la puntuación no es válida. A continuación, cada elemento se califica en una escala Likert de cuatro puntos, donde 1 significa “Rara vez o nunca”, 2 significa “Ocasionalmente/De vez en cuando”, 3 significa “Con frecuencia/A menudo” y 4 significa “Casi siempre o siempre”. Luego se considera la puntuación inversa, que se recodifican para mantener la coherencia del constructo. Una vez finalizado este paso, se suman los valores asignados (incluida la inversión correspondiente) para obtener la puntuación global. Si el análisis lo requiere, las puntuaciones se desglosan según la estructura del instrumento, que tiene en cuenta tres factores principales: cognitivo, motor e impulsividad no planificada. A continuación, estos factores se agrupan en subescalas (atención e inestabilidad cognitiva; motor y perseverancia; autocontrol y complejidad cognitiva) para ofrecer una imagen más detallada del perfil de impulsividad de la persona.

Validez y confiabilidad

Validez

La validez del instrumento se confirmó mediante la validez de contenido, evaluada según los criterios de los jueces y cuantificada utilizando el coeficiente V de Aiken, un método que facilitó la evaluación de la relevancia del contenido de los ítems para su uso en adolescentes. También se determinó que la validez de contenido alcanzó puntuaciones satisfactorias (superiores a 0,70), consideradas adecuadas para respaldar su aplicación en una muestra con características similares a las de la población objetivo del estudio (Flores, 2018).

Confiabilidad

Se determinó la confiabilidad mediante la consistencia interna utilizando el alfa de Cronbach y el omega de McDonald, lo que da como resultado un $\alpha = 0,699$ y un $\omega = 0,708$ para la escala, seleccionando este último como la estimación principal debido a su

estabilidad superior en relación con las cargas factoriales. El estudio demuestra que los índices obtenidos son adecuados para la aplicación del instrumento dentro de la muestra evaluada. Además, informa de la consistencia interna por dimensión mediante el omega compuesto ($\omega = 0,76$ para la impulsividad cognitiva, $\omega = 0,71$ para la impulsividad motora y $\omega = 0,77$ para la impulsividad no planificada), lo que confirma la fiabilidad del instrumento tanto en general como por factores específicos (Flores, 2018).

4.8. Técnicas de análisis de datos

Tras presentar la documentación necesaria para la aplicación de la prueba, los instrumentos se administraron en el centro educativo. Los datos resultantes se introdujeron en Excel, siguiendo el manual de corrección específico de cada instrumento.

Posteriormente, los datos se importaron a SPSS para obtener los estadísticos descriptivos. A continuación, se realizaron pruebas de normalidad correspondiente a una distribución distinta a lo normal, situación que permitió identificar el coeficiente adecuado para establecer relaciones entre las variables, empleando el coeficiente de spearman, al ser una prueba no paramétrica.

4.9. Aspectos éticos

La investigación se apegó a los principios señalados por la Asociación Americana de Psicología (APA, 2020).

El proyecto fue revisado por las personas encargadas de la universidad continental para corroborar que se consideraron todos los aspectos éticos en el trabajo de investigación con personas.

Asimismo, la recolección de la información es de fuentes confiables y cualquier alteración o ajuste de los datos se realizará de acuerdo con los lineamientos señalados en el documento de las Normas de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú, Capítulo III, Artículo 24 - (Colegio de Psicólogos del Perú, 2018).

CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1. Resultados de la investigación

En el siguiente apartado se presentan los hallazgos obtenidos posterior a la recopilación de datos de la muestra.

5.1.1. Resultados inferenciales

Como primer paso para determinar las correlaciones propuestas en los objetivos de la presente investigación, se obtuvo la normalidad de cada variable, mediante el coeficiente de Kolmogorov Smirnov, correspondiente al tener una muestra superior a los 50 participantes, con el fin de determinar el estadístico pertinente para establecer la correlación de los objetivos planteados.

Tabla 5

Prueba de normalidad de las variables

Variables	<i>P</i>	<i>n</i>
Autolesiones	.000	230
Impulsividad	.000	230

Nota. Elaboración propia.

Según la Tabla 5, se determinó que ambas variables obtuvieron una distribución no normal ($p = .000$, $p = .000$), situación que se interpreta que los datos de cada variable presentan una distribución diferente a lo normal; por lo tanto, se requiere el uso de pruebas no paramétricas siendo una de estas el coeficiente de correlación de Spearman.

Tabla 6

Correlación entre autolesiones e impulsividad

	Impulsividad
r_s	.636**

Autolesiones	<i>P</i>	.000
	<i>N</i>	230

Nota. Elaboración propia.

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 6, se evidencia una correlación positiva y muy significativa entre las variables autolesiones e impulsividad ($r_s = .636^{**}$, $p = .000$). Este resultado indica que existe una asociación directa de magnitud considerable entre ambas variables, de modo que, a mayores niveles de impulsividad, se incrementan también los niveles de conductas autolesivas, y, de manera inversa, cuando la impulsividad disminuye, las autolesiones tienden a reducirse. Esta relación sugiere que la impulsividad constituye un factor relevante en la manifestación de comportamientos autolesivos dentro del grupo evaluado.

Tabla 7

Correlación entre dimensión adaptabilidad e impulsividad

		Impulsividad
	r_s	.649 ^{**}
Dimensión adaptabilidad	<i>P</i>	.000
	<i>N</i>	230

Nota. Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 7, se observa una correlación positiva y muy significativa entre la dimensión adaptabilidad y la impulsividad ($r_s = .649^{**}$, $p = .000$). Este hallazgo evidencia una relación directa de magnitud considerable entre ambas variables, lo que significa que a medida que los niveles de adaptabilidad aumentan, también tienden a incrementarse los niveles de impulsividad, y de forma inversa, cuando la adaptabilidad disminuye, la impulsividad presenta valores menores. Este resultado sugiere que, en la población evaluada, la adaptabilidad se asocia estrechamente con la tendencia a responder de manera impulsiva ante diferentes

situaciones.

Tabla 8

Correlación entre dimensión regulación afectiva e impulsividad

		Impulsividad
	r_s	.821**
Dimensión regulación afectiva	P	.000
	N	230

Nota. Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 8, se identifica una correlación positiva y muy significativa entre la regulación afectiva y la impulsividad ($r_s = .821^*$, $p = .000$). Este resultado evidencia una asociación directa y de alta magnitud entre ambas variables, lo que indica que, a mayores niveles de regulación emocional, se observan también niveles elevados de impulsividad, y de forma inversa, cuando la regulación emocional disminuye, la impulsividad tiende a ser menor. Este hallazgo sugiere que, en la muestra analizada, la forma en que las personas gestionan sus emociones se relaciona estrechamente con su tendencia a responder de manera impulsiva ante distintas situaciones.

5.1.2. Resultados descriptivos

En este apartado se presentan los niveles alcanzados por cada variable.

5.1.2.1. Autolesiones

Tabla 9

Niveles de autolesiones

Autolesiones	F	%
Clínicamente	192	83.5%

insignificante		
Riesgo moderado	25	10.9%
Problema considerable	13	5.7%
Total	230	100.0%

Nota. Elaboración propia.

Según los datos obtenidos en la Tabla 9, se evidencia que de los estudiantes de un colegio de Andahuaylillas el 83.5 % alcanzó un interés clínicamente insignificante, mientras que un 10.9 % obtuvo un riesgo moderado, y el 5.7 % un grado de problema considerable.

5.1.2.2. Impulsividad

Tabla 10

Niveles de impulsividad

Impulsividad	F	%
Bajo	137	59.6%
Moderado	26	11.3%
Alto	67	29.1%
Total	230	100.0%

Nota. Elaboración propia.

Según la Tabla 10, se determinó que un 59.6 % obtuvo un grado bajo de impulsividad, mientras que el 11.3 % un grado moderado y un 29.1 % un grado alto de impulsividad, correspondiente a estudiantes de un colegio de Andahuaylillas.

5.2. Discusión de resultados

En el siguiente apartado se presenta la discusión de los hallazgos obtenidos en esta investigación.

Donde se planteó como objetivo general determinar la relación entre las autolesiones y la impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución

educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025. Los resultados indicaron una correlación directa y muy significativa entre las dos variables ($p = .000$; $r_s = .636^{**}$), lo que implica que un aumento de las autolesiones se correlaciona con una mayor propensión a los comportamientos impulsivos. Este hallazgo concuerda con el de Huamani (2020), quien identificó una correlación directa y sustancial entre la impulsividad y las autolesiones ($r = .954^{**}$; $p = .000$), y con el de Pary y Sánchez (2022), quienes descubrieron una asociación positiva entre la impulsividad y las autolesiones ($p = 0,05$). Además, las investigaciones nacionales sobre la prevalencia de las autolesiones entre los estudiantes, como la de Gutiérrez y Yáñez (2022), que indica que aproximadamente el 40 % de los estudiantes participan en conductas relacionadas con las autolesiones, indican que este problema puede observarse en los primeros años de la escuela secundaria y puede estar relacionado con dificultades en la autorregulación.

Encontrando respaldo a través del ciclo de autolesiones de Nock (2010), en el que la acumulación de emociones dolorosas aumenta la tensión y promueve conductas inadaptadas que producen alivio, un fenómeno que se intensifica cuando hay dificultad para articular y regular el malestar emocional (You et al., 2018) y una necesidad urgente de detener la “tormenta emocional” (Apicella et al., 2025). La idea de Barratt (1959, 1985) postula que la impulsividad se caracteriza por una propensión a reaccionar rápidamente sin prever las repercusiones, lo que se ajusta al fenómeno de las respuestas rápidas al malestar.

Los datos indican colectivamente que, entre los adolescentes, las autolesiones pueden funcionar como un enfoque inadaptado para obtener un alivio inmediato cuando el control inhibitorio es inadecuado y el malestar emocional se considera insoportable.

Como objetivos específicos se planteó determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución

educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025. Se encontró que la dimensión adaptabilidad presenta una correlación muy significativa con la impulsividad donde el $p=.000$ y $rs=.649^{**}$, de tipo directo. Este hallazgo concuerda con estudios que demuestran la correlación entre la autolesión y la impulsividad en adolescentes, como Huamani (2020) ($r = .954^{**}$; $p = .000$) y Pary y Sánchez (2022) ($p = 0,05$), lo que pone de relieve que, cuando los procesos de autorregulación se ven comprometidos, aumenta la probabilidad de comportamientos impulsivos asociados con la autolesión. También se relaciona con investigaciones anteriores que analizan la notable prevalencia de la impulsividad en entornos educativos, como Mendoza (2022), quien documentó niveles bajos, medios y altos de impulsividad tanto en hombres como en mujeres, y en particular al contexto local de Bustinza (2022), quien encontró un control impulsivo predominantemente regular (81,9 %) en Cusco, interpretado como una forma de autorregulación parcial susceptible a presiones emocionales o sociales.

A nivel teórico, esta relación puede analizarse a través del modelo de regulación afectiva de Mosquera (2008), que considera la autolesión como un mecanismo de afrontamiento de emociones intensas en contextos invalidantes, y la definición de impulsividad de Liqueste (2015), caracterizada por la inmediatez y la falta de planificación, que aclara cómo la disminución de las respuestas adaptativas a situaciones desafiantes puede conducir a comportamientos rápidos, reactivos y poco meditados.

De este modo, se evidencia que la impulsividad puede afianzarse como aprendizaje en entornos caracterizados por límites inadecuados, lo que obstaculiza las respuestas adaptativas y promueve reacciones rápidas.

El segundo objetivo específico propuso determinar la relación entre la dimensión regulación afectiva e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025. Se encontró que la

regulación emocional presenta una asociación muy significativa con la impulsividad donde el $p=.000$ y un $rs=.821^*$, de tipo directo. Este hallazgo concuerda con el trabajo de Pary y Sánchez (2022), quienes abordan explícitamente la desregulación emocional e identifican una correlación con la impulsividad en las autolesiones ($p = 0,05$), así como con Huamani (2020) ($r = 0,954^{**}$; $p = 0,000$). También se relaciona con la evidencia internacional que destaca la vulnerabilidad emocional asociada a la impulsividad, como Zuñiga (2022), quien indica que un autoconcepto subóptimo puede generar malestar emocional que se refleja en una alta impulsividad, y con Zazueta (2022), quien encontró un predominio de la impulsividad no planificada (40 %), una dimensión que es particularmente compatible con los comportamientos de descarga “en el momento”.

Teóricamente, este resultado se explica por el ciclo de Nock (2010), que postula que la tensión emocional acumulada y las dificultades para gestionarla aumentan la probabilidad de incurrir en conductas de alivio inmediato. De manera similar, Linehan (1993) sostiene que las autolesiones pueden evolucionar hasta convertirse en un mecanismo de afrontamiento aprendido para las crisis emocionales, mientras que Andover y Morris (2014) caracterizan la regulación afectiva como un proceso que ajusta la intensidad, la duración y la experiencia emocional, lo que impulsa la búsqueda de estrategias de control rápido. Moeller et al. (2001) definen la impulsividad como una respuesta rápida sin tener en cuenta las consecuencias adversas, lo que facilita la integración de ambos procesos: cuando se produce un desbordamiento emocional y disminuye el control inhibitorio, la autolesión puede manifestarse como un comportamiento regulador inadaptado inmediato.

El tercer objetivo específico fue establecer los niveles de autolesiones en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025, donde el 83.5 % alcanzó un interés

clínicamente no significativo, mientras que un 10.9 % obtuvo un riesgo moderado, y el 5.7 % un grado de problema considerable. Esta tendencia se asemeja a los hallazgos de Espinoza y Vergara (2021), quienes indicaron niveles mayoritariamente bajos de autolesiones (94,6 % bajos; 5,4 % medios) y una ausencia de niveles altos, lo que se ajusta a una distribución principalmente no grave. Sin embargo, los resultados son coherentes con los hallazgos locales de Paucar y Yupanqui (2024), quienes identificaron autolesiones en niveles leves, moderados y graves (30,7 % leves; 19,3 % moderadas; 12,7 % graves) y una relación significativa con las ideas suicidas ($p < 0,000$; $r = 0,769$). Esto refuerza la idea de que, incluso cuando la mayoría se encuentra en niveles no clínicos, las autolesiones sirven como señal de alerta debido a su posible asociación con un aumento de los riesgos. Además, el estudio clínico realizado por Jiménez (2023) ofrece una interpretación funcional al indicar que los cortes se realizan para aliviar el malestar emocional (71,4 %) y se producen predominantemente en los brazos y las muñecas (81,8 %), lo que se ajusta al concepto de la autolesión como mecanismo de afrontamiento.

Teóricamente, estos hallazgos se ven corroborados por el modelo alternativo de comportamiento suicida (Gallegos, 2017), que postula que la autolesión puede servir como un escape de impulsos más graves, y el modelo de castigo (Rodríguez y Guerrero, 2005), complementado por la dimensión de autocastigo articulada por Flores et al. (2018) y VelPalumbo et al. (2018), en el que la culpa y la internalización del castigo pueden perpetuar el comportamiento. En resumen, a pesar de la existencia de un nivel clínicamente menor, la presencia de un riesgo intermedio y de problemas sustanciales requiere apoyo preventivo, de detección temprana y educativo.

Como cuarto objetivo específico, se planteó determinar los niveles de impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi-Cusco, 2025, encontrando que el 59.6 % obtuvo un

grado bajo de impulsividad, mientras que el 11.3 % un grado moderado y un 29.1 % un grado alto de impulsividad. Este perfil es algo similar al que informaron Pary y Sánchez (2022) (45 % bajo; 43,3 % medio; 10,9 % alto) y al que informó Zuñiga (2024) a nivel local (70,1 % medio; 18,3 % bajo; 11,6 % alto). Esto muestra que la impulsividad tiende a concentrarse en rangos no extremos, aunque hay un alto porcentaje de niveles altos. Esto se relaciona con Bustinza (2024) (10,9 % bajo; 11,6 % alto), que muestra que la impulsividad suele encontrarse en rangos no extremos, pero hay un gran grupo de personas que son muy impulsivas (18,3 % bajo; 11,6 % alto), lo que sugiere que la impulsividad tiende a agruparse en categorías no extremas, pero con un gran porcentaje. Esto se asocia con Bustinza (2022), quien indicó un control impulsivo moderado (81,9 %) entre los estudiantes de Cusco, lo que respalda el concepto de autorregulación parcial. No obstante, contrasta con investigaciones como la de Santana (2023), que identificó una alta impulsividad en el 53,41 %, y la de Zuñiga (2022), que mostró un 79 % de alta impulsividad, lo que indica diversidad dentro de las muestras.

Dichos hallazgos pueden respaldarse teóricamente a través de la teoría de Barratt (1959, 1985) y sus dimensiones (cognitiva, motora y no planificada), junto con la teoría de Dickman (Figuerola, 2013), que distingue entre impulsividad funcional y disfuncional. Este marco aclara que ciertas respuestas rápidas pueden ser adaptativas; sin embargo, cuando se vuelven incontroladas, aumentan la susceptibilidad a comportamientos de riesgo. El enfoque característico de Eysenck (1959) aclara la propensión a comportamientos apresurados en perfiles específicos, mientras que el marco de Whiteside y Lynam (2001) de actos imprevistos que producen resultados adversos contextualiza los riesgos vinculados a la impulsividad elevada. En este sentido, los resultados descritos por Medina et al. (2017) y Segovia (2017) corroboran la idea de que un control inadecuado de los impulsos puede socavar la convivencia, intensificar los enfrentamientos y

promover comportamientos inadaptados.

La presencia de un porcentaje sustancial de alta impulsividad es particularmente significativa en este estudio, ya que se correlaciona notablemente con las autolesiones, lo que indica que las respuestas impulsivas pueden servir de catalizador para los comportamientos autolesivos en adolescentes que experimentan emociones intensas y carecen de estrategias de regulación eficaces.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Respecto al objetivo general, se concluye que existe una correlación positiva y muy significativa entre las variables autolesiones e impulsividad ($r_s = .636^{**}$, $p = .000$). Este resultado demuestra que, a mayores niveles de impulsividad, se incrementan las conductas autolesivas, evidenciando una relación directa, consistente y estadísticamente significativa entre ambas variables en la población estudiada.

SEGUNDO: Respecto al segundo objetivo específico, los resultados indican que la dimensión de adaptabilidad mantiene una correlación positiva y muy significativa con la impulsividad ($r_s = .649^{**}$, $p = .000$), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1). Esto implica que a medida que aumentan los niveles de adaptabilidad, también se elevan los grados de impulsividad, reflejando una relación directa entre ambas variables.

TERCERO: En cuanto al tercer objetivo específico, se observó que la regulación emocional presenta una asociación muy significativa y de alta magnitud con la impulsividad ($r_s = .821^{**}$, $p = .000$), lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna (H2). Este resultado sugiere que una menor capacidad para regular las emociones se asocia con una mayor tendencia a la impulsividad, confirmando la estrecha relación entre ambas dimensiones.

CUARTO: Referente al cuarto objetivo específico, los resultados descriptivos muestran que, en la variable autolesiones, un 83.5 % de los participantes presentó niveles clínicamente no significativos, un 10.9 % riesgo moderado y un 5.7 % problemas autolesivos considerables. Estos datos evidencian que la mayoría de los evaluados no presenta una tendencia autolesiva preocupante, aunque existe un grupo reducido que requiere seguimiento psicológico especializado.

QUINTO: Finalmente, respecto al quinto objetivo específico, en la variable impulsividad se encontró que un 59.6 % de los participantes presenta un nivel bajo, un 11.3 % nivel moderado y un 29.1 % nivel alto. Esto indica que, si bien la mayoría muestra un adecuado control de los impulsos, una proporción considerable exhibe niveles elevados de impulsividad, constituyendo un posible factor de riesgo para la aparición de conductas autolesivas.

RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se recomienda a la institución educativa considerar los resultados obtenidos en esta investigación como base para diseñar e implementar estrategias pedagógicas y preventivas orientadas a la regulación de conductas impulsivas y la reducción del riesgo de autolesiones. Para ello, se sugiere fortalecer las escuelas de padres, realizar reuniones semanales con el equipo de tutoría y promover acciones formativas integrales que favorezcan el desarrollo emocional de los estudiantes.

SEGUNDO: Se recomienda a los padres de familia fomentar espacios de diálogo y comunicación activa con sus hijos, especialmente considerando que un 10.9 % de los estudiantes presenta riesgo moderado y un 5.7 % evidencia un problema considerable en relación con las autolesiones. Es fundamental que las familias brinden apoyo emocional y faciliten el acceso oportuno a atención psicológica especializada, tanto para los adolescentes con conductas autolesivas como para aquellos que presentan niveles altos de impulsividad.

TERCERO: Se recomienda a los docentes y equipo tutorial rediseñar el plan tutorial anual, incorporando estrategias educativas enfocadas en el control emocional, la adaptabilidad y la prevención de autolesiones. Asimismo, se sugiere trabajar en el fortalecimiento de la autoestima, las habilidades emocionales y la implementación de pausas activas durante la jornada escolar, a fin de optimizar el bienestar y la regulación emocional del alumnado.

CUARTO: Se recomienda a la Municipalidad de Andahuaylillas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, diseñar y ejecutar un proyecto socioemocional comunitario centrado en el desarrollo de habilidades emocionales, la valoración personal y la promoción de la autoestima en adolescentes. Esta intervención deberá priorizar el

enfoque preventivo y promocional en salud mental, considerando que los jóvenes representan un pilar esencial para el desarrollo sostenible del distrito.

QUINTO: Se recomienda a futuros investigadores realizar estudios correlacionales y comparativos con muestras más amplias y diversas, que permitan profundizar en la comprensión de la problemática de las autolesiones e impulsividad en adolescentes del distrito de Andahuaylillas. Estos estudios contribuirán a precisar con mayor validez la magnitud del problema y orientar estrategias de intervención más eficaces.

REFERENCIAS

- Allen, C. (2007). *Self-harm: The short-term treatment and management of self-harm in primary and secondary care*. National Institute for Clinical Excellence.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5.^a ed.). APA.
- Ancajima, B. (2021). *Conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública de Talara, 2020* [Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- Apicella, M., et al. (2025). Non-suicidal self-injury in adolescents: A clinician's guide. *Frontiers in Psychiatry*, 16(3), 1–10.
- Arrieta, C. (2020). *Conductas autolesivas en adolescentes: Una mirada desde la psicología clínica*. Editorial Académica Española.
- Barratt, E. (1959). Anxiety and impulsiveness related to psychomotor efficiency. *Perceptual and Motor Skills*, 9(3), 191–198.
<https://doi.org/10.2466/pms.1959.9.3.191>
- Barratt, E. (1985). Impulsiveness subtraits: Arousal and information processing. In J. T. Spence & C. E. Izard (Eds.), *Motivation, emotion, and personality* (pp. 137–146). Elsevier.
- Barratt, E. (1994). Impulsiveness and aggression. In J. Monahan & H. J. Steadman (Eds.), *Violence and mental disorder: Developments in risk assessment* (pp. 61–79). University of Chicago Press.
- Bechara, A. (2005). Decision making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: A neurocognitive perspective. *Nature Neuroscience*, 8(11), 1458–1463.
<https://doi.org/10.1038/nn1584>

- Begazo, S. (2023). *Estados emocionales alterados y su relación con la calidad de vida del personal de salud desde un enfoque psiconeuroinmunológico de un hospital de Majes* [Tesis de pregrado, Universidad Continental]. Universidad Continental.
- Cyders, M., & Coskunpinar, A. (2011). Measurement of constructs using self-report and behavioral lab tasks: Is there overlap in nomothetic span and construct representation for impulsivity? *Clinical Psychology Review*, 31(6), 965–982.
<https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.001>
- Dannemann, V. (2023). *América Latina en alerta por aumento en tasas de suicidio*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-en-alerta-por-aumento-en-tasas-de-suicidio/a-65493663>
- Eckart, K. (2021). *Thoughts and plans of adolescents around suicide*. University of Washington News. <https://www.washington.edu/news/2021/09/14/study-examines-teens-thoughts-plans-around-suicide/>
- Espinoza, P., & Vergara, C. (2021). *Conductas autolesivas en adolescentes de segundo y tercer año de secundaria de una institución educativa de Supe, Barranca, 2020* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Universidad César Vallejo.
- Evenden, J. (1999). Varieties of impulsivity. *Psychopharmacology*, 146(4), 348–361.
<https://doi.org/10.1007/PL00005481>
- Favazza, A. (1996). *Bodies under siege: Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry* (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.
- Favazza, A. (1998). The coming of age of self-mutilation. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 186(5), 259–268.

- Figuerola, A. (2013). Impulsividad: Perspectivas teóricas y hallazgos empíricos. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 15(1), 111–127.
- Flores, R., Cancino, M., & Figuerola, J. (2018). Prácticas culturales y rituales: Significados y transformaciones en comunidades latinoamericanas. *Revista Latinoamericana de Estudios Sociales*, 14(2), 45–60.
- García, A. (2023). *Violencia familiar y autolesión en estudiantes adolescentes de la I.E. Hermógenes Arenas Yáñez, Tacna, 2023* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Universidad César Vallejo.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/129227/Garc%c3>
- García, R. (2020). *Prácticas parentales y autolesión no suicida en adolescentes escolarizados* [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Aguascalientes]. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Hamilton, K., Littlefield, A., & Sher, K. (2015). Clarifying the relationship between impulsivity and substance use disorders: Methodological challenges and future directions. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 6(2), 182–198. <https://doi.org/10.1037/per0000097>
- Huamani, L. (2020). *Impulsividad y autolesión en adolescentes de dos instituciones educativas públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso–Callao, 2019* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Universidad César Vallejo.
- Instituto Nacional de Salud Mental. (2021). *Estudio epidemiológico de salud mental en niños y adolescentes en Lima Metropolitana. Anales de Salud Mental*.
- Jiménez, S., et al. (2023). Evaluación de conductas de autolesiones en una muestra de adolescentes atendidos en salud mental infanto-juvenil. *Revista de Psiquiatría Infantil*, 40(3), 24–37. <https://doi.org/10.31766/revpsij.v40n3a4>

- Liquete, V. (2015). Psicología de la personalidad: Aportes de Eysenck al estudio del temperamento. *Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento*, 6(2), 45–59.
- McAllister, A. (2003). Multiple meanings of self-harm: A critical review. *International Journal of Mental Health Nursing*, 12(3), 177–185.
<https://doi.org/10.1046/j.1440-0979.2003.00284.x>
- Ministerio de Salud Pública. (2023). *Suicidio en adolescentes en Uruguay*.
<https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Suicidio%20en%20adolescentes%20en>
- Moeller, F., Barratt, E., Dougherty, D., Schmitz, J., & Swann, A. (2001). Psychiatric aspects of impulsivity. *American Journal of Psychiatry*, 158(11), 1783–1793.
<https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.11.1783>
- Nock, M. (2010). Self-injury: An integrated model of the development and maintenance of non-suicidal self-injury. *Annual Review of Clinical Psychology*, 6(1), 339–363. <https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131258>
- Organización Mundial de la Salud. (2024). *Salud mental del adolescente*.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Pari, K., & Sanchez, W. (2022). *Desregulación emocional e impulsividad asociadas a las autolesiones sin intención suicida en adolescentes de Lima Metropolitana* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Universidad César Vallejo.
- Patton, J., Stanford, M., & Barratt, E. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. *Journal of Clinical Psychology*, 51(6), 768–774.
[https://doi.org/10.1002/1097-4679\(199511\)51:6](https://doi.org/10.1002/1097-4679(199511)51:6)
- Sánchez, J. (2020). *Factores psicosociales asociados a la tendencia suicida en adolescentes del 5to nivel secundario de una institución educativa pública del*

- Cusco, 2019 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco]. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
<https://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12918/5368/253T20200167.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sharma, L., Markon, K., & Clark, L. (2014). Toward a theory of distinct types of “impulsive” behaviors: A meta-analysis of self-report and behavioral measures. *Psychological Bulletin*, 140(2), 374–408. <https://doi.org/10.1037/a0034418>
- Squillace, M., Picón, P., & Schmidt, V. (2011). Impulsividad y personalidad: Un análisis desde el modelo de Dickman. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 3(1), 17–25.
- Stanford, M., Mathias, C., Dougherty, D., Lake, S., Anderson, N., & Patton, J. (2009). Fifty years of the Barratt Impulsiveness Scale: An update and review. *Personality and Individual Differences*, 47(5), 385–395.
<https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.04.008>
- UNICEF. (2022). *Campaña de cuidado sobre la salud mental*.
<https://www.unicef.org/bolivia/comunicados-prensa/la-l%C3%ADnea-gratuita-familia-segura-de-unicef-lanza-campa%C3%B1a-navide%C3%B1a-para-cuidar-la>
- Ursui, A. (2022). *Riesgo de suicidio y estrategias de afrontamiento ante el estrés, en una muestra de adolescentes colombianos* [Tesis de posgrado, Universidad de Córdoba]. Universidad de Córdoba.
- Whiteside, S., & Lynam, D. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. *Personality and Individual Differences*, 30(4), 669–689. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00064-7](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00064-7)

You, J., Ren, Y., Zhang, X., Wu, Z., & Lin, M. (2018). Emotion dysregulation and nonsuicidal self-injury: A meta-analytic review. *Neuropsychiatry*, 8(2), 733–748.

Zuñiga, F. (2022). *Autoconcepto e impulsividad en adolescentes que cometieron agresión sexual* [Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés].
Universidad Mayor de San Andrés.